

제19권 제36호 2026. 9. 17.

I. 환자감사: 전수감시 감염병 주간 발생 현황

1. 2026년 37주차 보고 현황(2026. 9. 12. 기준)*

단위 : 보고환자수[†]

감염병*	금주	2026년 누계	5년간 주별 평균	연간현황					금주 해외유입현황 : 국가명 (신고수)
				2025	2024	2023	2022	2021	
제2급감염병									
결핵**	366	12,518	345	17,070	17,944	19,540	20,383	22,904	필리핀(1)
수두	283	23,567	344	30,248	31,892	26,964	18,547	20,929	
홍역	0	10	0	78	49	8	0	0	
콜레라	0	0	0	0	0	0	0	0	
장티푸스	1	16	1	33	34	19	38	61	
파라티푸스	0	6	1	24	23	22	31	29	미국(1)
세균성이질	0	30	1	64	41	37	31	18	
장출혈성대장균감염증	0	466	7	531	274	216	211	165	
A형간염	27	1,247	44	1,141	1,168	1,324	1,890	6,583	
백일해	1	291	175	5,491	48,048	292	31	21	
유행성이하선염	87	3,912	126	6,720	6,425	7,737	6,358	9,708	
풍진	0	0	0	0	0	0	0	0	
수막구균 감염증	0	7	0	12	17	11	3	2	
폐렴구균 감염증	4	306	5	440	451	431	339	269	
한센병	0	5	0	3	5	3	2	5	
성홍열	82	8,686	74	13,113	6,642	815	505	678	
반코마이신내성황색포도알균 (VRSA) 감염증	0	2	0	2	1	2	1	3	
카바페넴내성장내세균목 (CRE) 감염증	1,139	39,783	813	49,053	42,345	38,405	30,543	23,310	
E형간염	6	524	14	915	756	572	528	494	
제3급감염병									
파상풍	2	15	1	24	29	24	23	21	몰디브(2), 베트남(5), 인도네시아(1), 태국(중국 (베트남)으로(1))
B형간염	2	161	6	315	315	315	332	453	
일본뇌염	0	1	1	7	21	17	11	23	
C형간염	67	3,659	131	5,639	6,444	7,249	8,308	10,116	
말라리아	9	303	18	601	713	747	420	294	
레지오넬라증	9	549	11	640	452	476	415	383	
비브리오패혈증	1	21	4	68	49	69	46	52	
발진열	0	3	0	16	60	21	4	9	
쯔쯔가무시증	3	135	23	3,405	6,268	5,663	6,235	5,915	
렙토스피라증	0	18	2	53	70	59	125	144	
브루셀라증	0	2	0	4	5	5	5	4	
신증후군출혈열	2	85	5	230	373	452	302	310	
후천성면역결핍증(AIDS)***	13	503	15	659	715	750	825	770	
크로이츠펠트-야콥병(CJD)	0	38	1	99	67	67	61	68	
댕기열	9	62	3	110	196	206	103	3	
큐열	1	78	2	72	57	57	56	46	
라임병	0	27	1	41	34	45	22	8	
유비저	0	2	0	5	2	2	2	2	
치쿤구니야열	0	6	0	9	9	13	8	0	
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	1	97	6	280	170	198	193	172	
지카바이러스감염증	0	3	0	3	0	2	3	0	
엡폭스(원숭이두창)	1	13	-	27	17	151	4	-	
매독	33	1,379	-	2,211	2,790	-	-	-	태국(2), 베트남(1)
매독(1기)	16	504	-	721	983	-	-	-	
매독(2기)	8	290	-	449	524	-	-	-	
매독(3기)	0	44	-	50	51	-	-	-	
매독(선천성)	0	8	-	12	12	-	-	-	
매독(잠복)	18	639	-	979	1,220	-	-	-	

* 2026년 통계는 변동가능한 잠정통계이며, 2026년 누계는 1주부터 금주까지의 누계를 말함

** 결핵은 2025년부터 전제환자(신환자), 재치료자(재발자, 실패 후 재치료자, 중단 후 재치료자, 이전 치료결과 불명확), 과거 치료여부 불명확) 수로 산출함

*** 후천성면역결핍증(AIDS) 통계는 내국인만 집계된 통계이며, HIV 감염을 모두 포함함

† 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고건을 포함하며, AIDS는 내국인만을 포함함

‡ 미포함 질병: 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 보툴리눔독소증, 야토병, 신종감염
병증후군, 중증급성호흡기증후군(SARS), 중증호흡기증후군(MERS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 니파바이러스감염증, 폴리오, b형헤
모필루스인플루엔자, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염

§ 최근 5년(2021~2025년)의 해당 주의 신고 건수와 이전 2주, 이후 2주 동안의 신고 건수(총 25주) 평균임

2. 지역별 보고 현황(2026. 9. 12. 기준)(37주차)*

단위 : 보고환자수†

지역	제2급감염병											
	결핵**			수두			홍역			콜레라		
	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡
전국	366	12,518	13,493	283	23,567	17,992	0	10	0	0	0	0
서울	58	2,034	2,246	43	3,047	2,168	0	3	0	0	0	0
전남광주§	32	997	1,057	19	1,561	1,414	0	0	0	0	0	0
부산	29	800	863	17	1,238	1,038	0	0	0	0	0	0
대구	14	570	638	12	1,136	1,034	0	0	0	0	0	0
인천	21	695	717	16	904	801	0	1	0	0	0	0
대전	11	321	297	11	448	456	0	0	0	0	0	0
울산	6	234	251	3	571	460	0	0	0	0	0	0
세종	1	50	59	1	295	170	0	0	0	0	0	0
경기	75	2,792	2,996	97	7,105	5,077	0	3	0	0	0	0
강원	14	505	563	5	620	570	0	0	0	0	0	0
충북	10	399	451	11	595	624	0	1	0	0	0	0
충남	20	681	709	15	1,000	649	0	1	0	0	0	0
전북	10	523	561	14	1,222	619	0	1	0	0	0	0
경북	30	964	1,057	0	1,232	950	0	0	0	0	0	0
경남	25	790	859	16	1,952	1,455	0	0	0	0	0	0
제주	10	163	168	3	641	507	0	0	0	0	0	0

* 2026년 통계는 변동가능한 잠정통계이며, 2026년 누계는 1주부터 금주까지의 누계를 말함

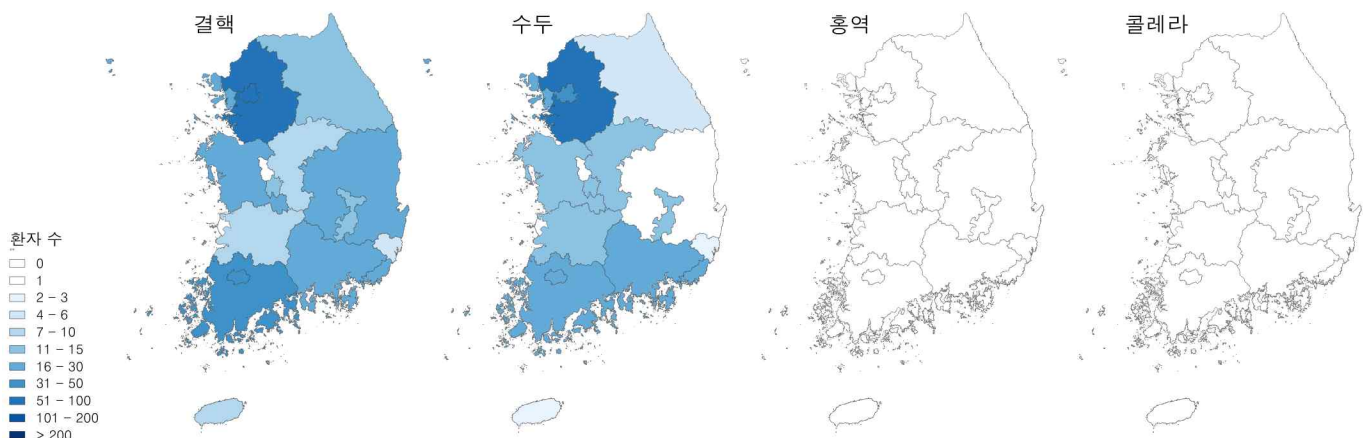
** 결핵은 2025년부터 전체환자(신환자(초치료자), 재치료자(재발자, 실패 후 재치료자, 중단 후 재치료자, 이전 치료결과 불명확), 과거 치료여부 불명확) 수로 산출함

† 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함함

‡ 최근 5년(2021~2025년)의 1주부터 해당 주까지 누계의 평균임

§ 지방행정체제 개편으로 2026.7월부터 광주광역시와 전라남도가 전남광주통합특별시로 통합되었으며 전남광주 누계 통계는 광주, 전남, 전남광주 신고건 합임

※ 금주 감염병별 시도 보고 환자수 현황



2. 지역별 보고 현황(2026. 9. 12. 기준)(37주차)*

단위 : 보고환자수†

지역	제2급감염병											
	장티푸스			파라티푸스			세균성이질			장출혈성대장균감염증		
	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡
전국	1	16	27	0	6	16	0	30	30	0	466	214
서울	0	2	4	0	1	3	0	11	4	0	70	33
전남광주§	0	2	2	0	1	2	0	0	3	0	72	38
부산	1	2	3	0	0	2	0	3	2	0	20	6
대구	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	21	10
인천	0	0	1	0	1	1	0	3	2	0	32	11
대전	0	0	1	0	1	0	0	2	3	0	21	7
울산	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	8	3
세종	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	2
경기	0	6	6	0	0	5	0	9	8	0	96	49
강원	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	6
충북	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5
충남	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	32	9
전북	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	19	6
경북	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	25	13
경남	0	2	3	0	0	1	0	1	1	0	21	11
제주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5

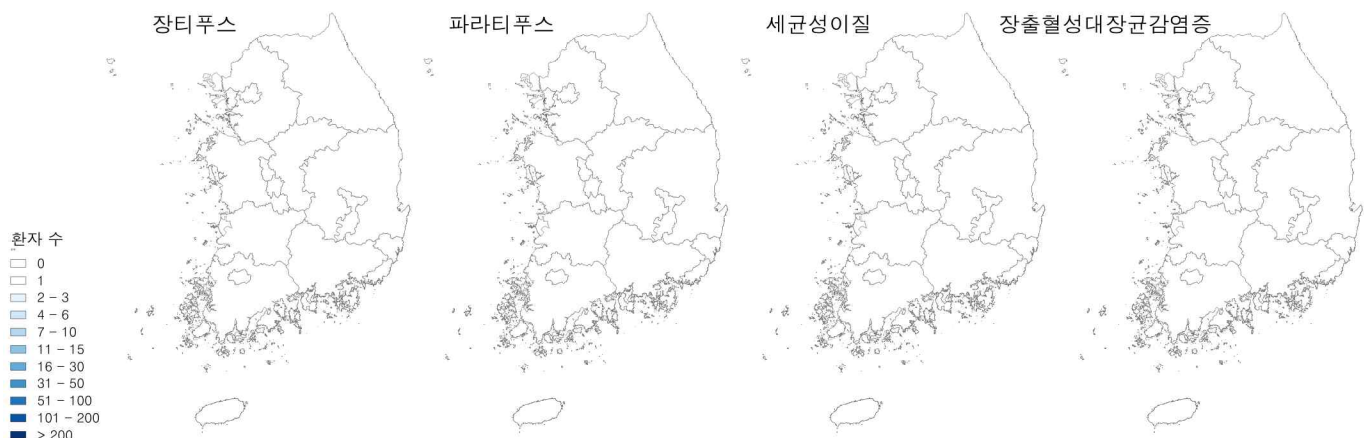
* 2026년 통계는 변동가능한 잠정통계이며, 2026년 누계는 1주부터 금주까지의 누계를 말함

† 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함함

‡ 최근 5년(2021~2025년)의 1주부터 해당 주까지 누계의 평균임

§ 지방행정체제 개편으로 2026.7월부터 광주광역시와 전라남도가 전남광주통합특별시로 통합되었으며 전남광주 누계 통계는 광주, 전남, 전남광주 신고건 합임

※ 금주 감염병별 시도 보고 환자수 현황



2. 지역별 보고 현황(2026. 9. 12. 기준)(37주차)*

단위 : 보고환자수†

지역	제2급감염병											
	A형간염			백일해			유행성이하선염			풍진		
	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡
전국	27	1,247	1,817	1	291	5,470	87	3,912	5,369	0	0	0
서울	2	205	362	0	29	682	15	540	707	0	0	0
전남광주§	2	64	81	0	18	319	4	265	393	0	0	0
부산	0	22	48	1	28	283	4	179	252	0	0	0
대구	1	30	41	0	8	158	6	207	257	0	0	0
인천	1	130	136	0	34	603	5	216	287	0	0	0
대전	0	28	53	0	9	160	3	106	144	0	0	0
울산	0	12	15	0	12	61	4	123	186	0	0	0
세종	0	9	12	0	7	57	1	24	44	0	0	0
경기	15	396	645	0	58	1,579	32	1,175	1,595	0	0	0
강원	0	22	43	0	5	109	5	159	206	0	0	0
충북	0	41	73	0	5	114	2	92	154	0	0	0
충남	3	67	111	0	6	141	1	197	259	0	0	0
전북	1	128	81	0	5	180	5	131	190	0	0	0
경북	0	50	48	0	10	245	0	135	217	0	0	0
경남	0	21	33	0	55	623	0	302	387	0	0	0
제주	2	22	35	0	2	156	0	61	91	0	0	0

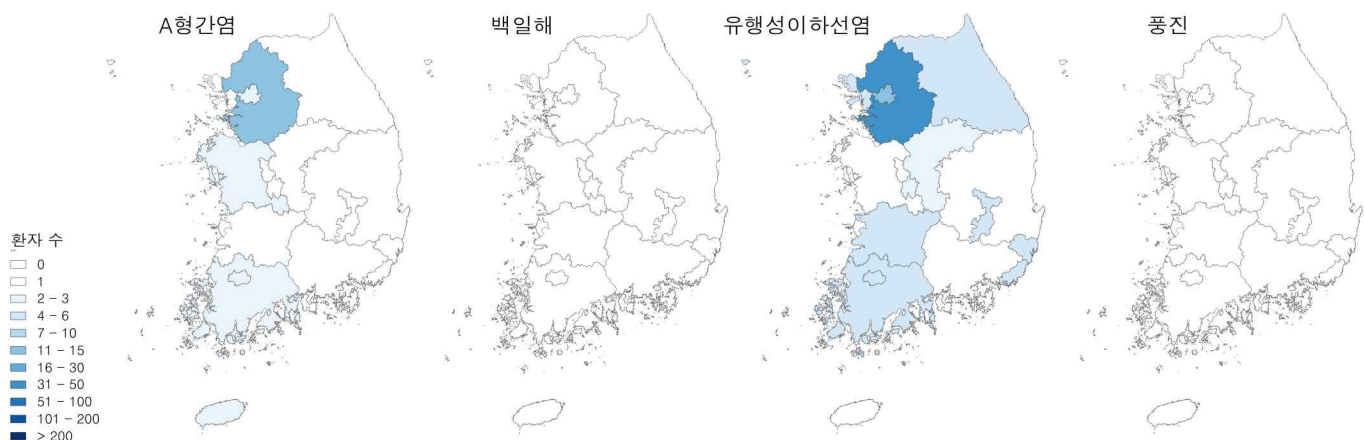
* 2026년 통계는 변동가능한 잠정통계이며, 2026년 누계는 1주부터 금주까지의 누계를 말함

† 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함함

‡ 최근 5년(2021~2025년)의 1주부터 해당 주까지 누계의 평균임

§ 지방행정체제 개편으로 2026.7월부터 광주광역시와 전라남도가 전남광주통합특별시로 통합되었으며 전남광주 누계 통계는 광주, 전남, 전남광주 신고건 합임

※ 금주 감염병별 시도 보고 환자수 현황



2. 지역별 보고 현황(2026. 9. 12. 기준)(37주차)*

단위 : 보고환자수†

지역	제2급감염병						제3급감염병					
	수막구균 감염증			성홍열			파상풍			B형간염		
	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡
전국	0	7	5	82	8,686	3,070	2	15	17	2	161	230
서울	0	1	2	11	1,140	439	0	0	2	1	34	35
전남광주§	0	0	0	8	609	170	0	3	0	0	20	15
부산	0	0	0	2	802	167	0	1	1	0	8	14
대구	0	1	0	1	360	56	0	1	1	0	7	8
인천	0	2	0	8	899	286	0	0	2	0	8	15
대전	0	0	0	1	285	77	0	0	0	0	5	6
울산	0	0	0	2	251	53	0	0	0	0	2	3
세종	0	0	0	0	66	13	0	0	0	0	1	1
경기	0	2	3	35	2,615	986	0	2	3	1	38	69
강원	0	0	0	1	131	127	0	0	1	0	4	7
충북	0	0	0	1	183	91	1	2	1	0	7	7
충남	0	0	0	5	452	155	1	3	2	0	4	15
전북	0	0	0	5	139	44	0	1	1	0	4	9
경북	0	0	0	2	175	158	0	2	1	0	6	9
경남	0	0	0	0	513	217	0	0	2	0	10	14
제주	0	1	0	0	66	31	0	0	0	0	3	3

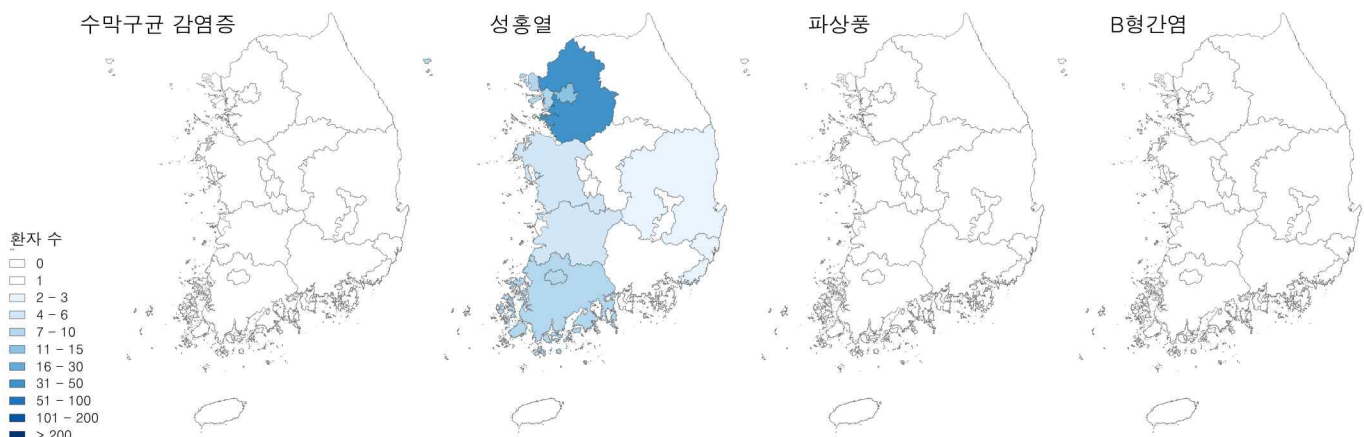
* 2026년 통계는 변동가능한 잠정통계이며, 2026년 누계는 1주부터 금주까지의 누계를 말함

† 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함함

‡ 최근 5년(2021~2025년)의 1주부터 해당 주까지 누계의 평균임

§ 지방행정체제 개편으로 2026.7월부터 광주광역시와 전라남도가 전남광주통합특별시로 통합되었으며 전남광주 누계 통계는 광주, 전남, 전남광주 신고건 합임

※ 금주 감염병별 시도 보고 환자수 현황



2. 지역별 보고 현황(2026. 9. 12. 기준)(37주차)*

단위 : 보고환자수†

지역	제3급감염병											
	일본뇌염			말라리아			레지오넬라증			비브리오패혈증		
	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡
전국	0	1	1	9	303	458	9	549	321	1	21	30
서울	0	0	0	1	36	58	2	155	68	0	1	4
전남광주§	0	0	0	0	4	9	0	18	20	0	4	6
부산	0	0	0	0	3	6	0	18	12	0	4	2
대구	0	0	0	0	3	3	0	34	19	0	0	0
인천	0	0	0	2	50	75	1	33	23	0	0	2
대전	0	0	0	0	3	4	1	12	7	0	0	1
울산	0	0	0	0	1	3	1	9	2	0	0	0
세종	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0
경기	0	1	0	5	168	261	3	147	86	0	3	6
강원	0	0	0	1	21	20	0	19	6	0	1	0
충북	0	0	0	0	3	3	0	12	8	0	0	0
충남	0	0	0	0	2	5	0	14	8	0	2	2
전북	0	0	0	0	2	2	0	15	7	1	3	0
경북	0	0	0	0	4	4	1	23	18	0	0	2
경남	0	0	1	0	2	3	0	24	17	0	3	5
제주	0	0	0	0	1	1	0	13	19	0	0	0

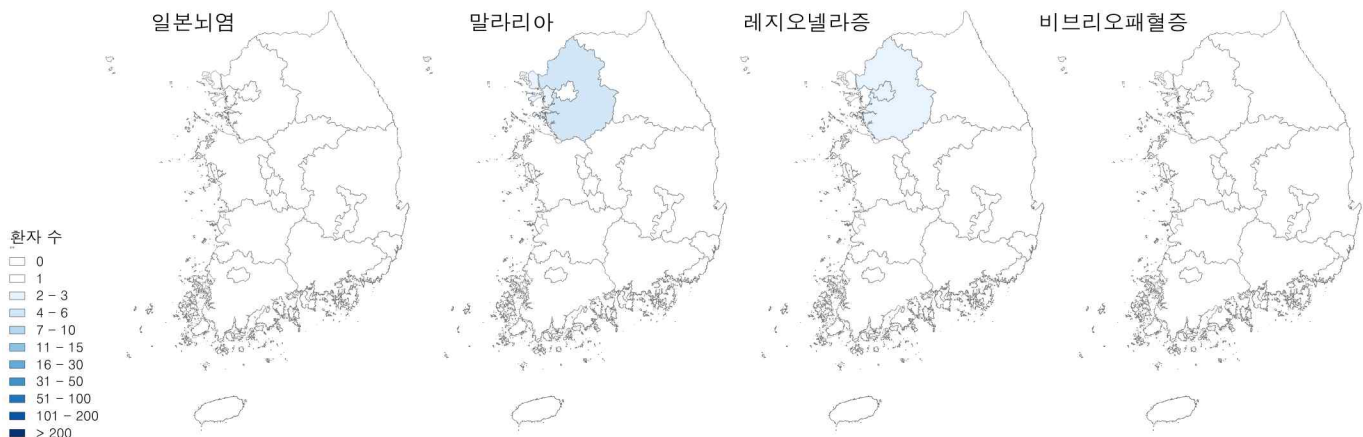
* 2026년 통계는 변동가능한 잠정통계이며, 2026년 누계는 1주부터 금주까지의 누계를 말함

† 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함함

‡ 최근 5년(2021~2025년)의 1주부터 해당 주까지 누계의 평균임

§ 지방행정체제 개편으로 2026.7월부터 광주광역시와 전라남도가 전남광주통합특별시로 통합되었으며 전남광주 누계 통계는 광주, 전남, 전남광주 신고건 합임

※ 금주 감염병별 시도 보고 환자수 현황



2. 지역별 보고 현황(2026. 9. 12. 기준)(37주차)*

단위 : 보고환자수†

지역	제3급감염병											
	발진열			쯔쯔가무시증			렙토스피라증			브루셀라증		
	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡
전국	0	3	11	3	135	717	0	18	44	0	2	3
서울	0	0	1	0	7	14	0	0	1	0	0	0
전남광주§	0	0	1	1	22	236	0	4	10	0	0	1
부산	0	0	1	0	6	20	0	0	2	0	1	0
대구	0	0	0	0	2	7	0	1	0	0	0	0
인천	0	1	3	0	0	5	0	0	1	0	0	0
대전	0	0	0	0	1	13	0	1	1	0	0	0
울산	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0
세종	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
경기	0	1	2	0	9	33	0	1	3	0	0	1
강원	0	0	0	0	4	7	0	0	2	0	0	0
충북	0	0	0	0	3	12	0	1	2	0	0	0
충남	0	0	1	1	10	55	0	6	9	0	0	0
전북	0	1	1	0	23	128	0	3	6	0	0	0
경북	0	0	0	0	3	17	0	1	4	0	1	0
경남	0	0	1	1	39	154	0	0	3	0	0	1
제주	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0

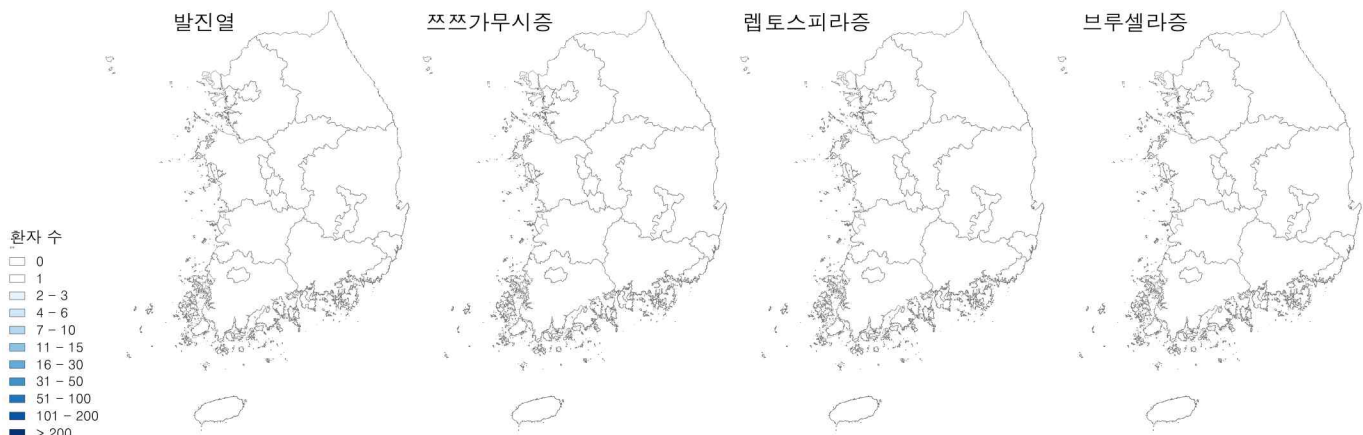
* 2026년 통계는 변동가능한 잠정통계이며, 2026년 누계는 1주부터 금주까지의 누계를 말함

† 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함함

‡ 최근 5년(2021~2025년)의 1주부터 해당 주까지 누계의 평균임

§ 지방행정체제 개편으로 2026.7월부터 광주광역시와 전라남도가 전남광주통합특별시로 통합되었으며 전남광주 누계 통계는 광주, 전남, 전남광주 신고건 합임

※ 금주 감염병별 시도 보고 환자수 현황



2. 지역별 보고 현황(2026. 9. 12. 기준)(37주차)*

단위 : 보고환자수†

지역	제3급감염병											
	신증후군출혈열			크로이츠펔트-야콥병(CJD)			뎅기열			큐열		
	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡
전국	2	85	161	0	38	49	9	62	82	1	78	95
서울	0	3	2	0	3	10	2	14	25	0	9	11
전남광주§	0	14	33	0	0	3	2	5	5	0	3	3
부산	0	1	3	0	3	5	0	2	5	0	0	2
대구	0	1	2	0	0	2	0	3	1	1	5	1
인천	0	3	2	0	4	3	1	4	7	0	0	10
대전	0	1	2	0	2	1	1	4	1	0	1	3
울산	0	1	1	0	4	1	0	1	1	0	1	1
세종	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
경기	0	7	25	0	12	14	2	12	23	0	16	44
강원	0	4	12	0	1	2	0	4	2	0	2	2
충북	1	6	3	0	2	1	0	2	2	0	6	6
충남	0	14	21	0	1	1	0	3	2	0	13	5
전북	1	7	27	0	1	1	1	2	2	0	4	1
경북	0	17	10	0	2	2	0	0	2	0	14	4
경남	0	6	14	0	2	2	0	3	3	0	3	2
제주	0	0	3	0	1	1	0	2	1	0	0	0

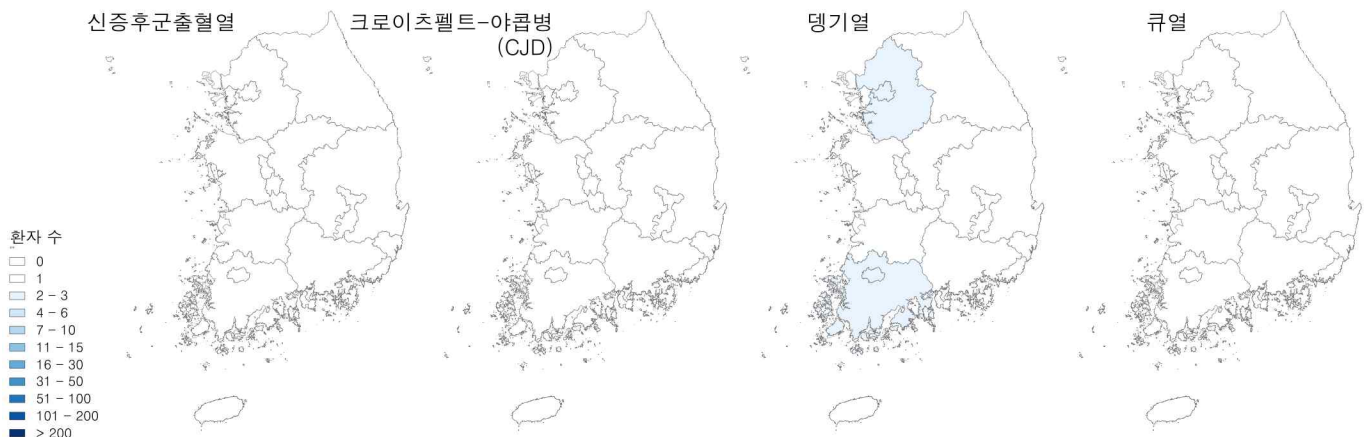
* 2026년 통계는 변동가능한 잠정통계이며, 2026년 누계는 1주부터 금주까지의 누계를 말함

† 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함함

‡ 최근 5년(2021~2025년)의 1주부터 해당 주까지 누계의 평균임

§ 지방행정체제 개편으로 2026.7월부터 광주광역시와 전라남도가 전남광주통합특별시로 통합되었으며 전남광주 누계 통계는 광주, 전남, 전남광주 신고건 합임

※ 금주 감염병별 시도 보고 환자수 현황



2. 지역별 보고 현황(2026. 9. 12. 기준)(37주차)*

단위 : 보고환자수†

지역	제3급감염병								
	라임병			중증열성혈소판감소증후군(SFTS)			지카바이러스감염증		
	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡	금주	2026년 누계	5년 누계 평균‡
전국	0	27	18	1	97	127	0	3	0
서울	0	4	5	0	7	7	0	1	0
전남광주§	0	0	0	1	6	10	0	1	0
부산	0	0	0	0	3	2	0	0	0
대구	0	0	0	0	3	5	0	1	0
인천	0	2	2	0	5	1	0	0	0
대전	0	0	0	0	2	2	0	0	0
울산	0	0	0	0	1	4	0	0	0
세종	0	0	0	0	1	2	0	0	0
경기	0	11	6	0	13	19	0	0	0
강원	0	3	0	0	9	13	0	0	0
충북	0	1	1	0	3	6	0	0	0
충남	0	3	1	0	9	8	0	0	0
전북	0	0	0	0	9	9	0	0	0
경북	0	2	1	0	11	18	0	0	0
경남	0	0	2	0	8	12	0	0	0
제주	0	1	0	0	7	9	0	0	0

* 2026년 통계는 변동가능한 잠정통계이며, 2026년 누계는 1주부터 금주까지의 누계를 말함

† 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함함

‡ 최근 5년(2021~2025년)의 1주부터 해당 주까지 누계의 평균임

§ 지방행정체제 개편으로 2026.7월부터 광주광역시와 전라남도가 전남광주통합특별시로 통합되었으며 전남광주 누계 통계는 광주, 전남, 전남광주 신고건 합임

※ 금주 감염병별 시도 보고 환자수 현황



II. 환자감시 : 표본감시 감염병 주간 발생 현황

1. 인플루엔자 주간 발생 현황(36주차, 2026. 9. 5. 기준)

- 외래환자 1,000명당 의사환자분율(ILI): 25.3명(=2.5%)
- 변동(주간): 2026년 35주차(13.3명) 대비 증가
- 표본보고기관: 778개 의료기관
- ※ 2026-2027절기 유행기준은 12.9명(/1,000)

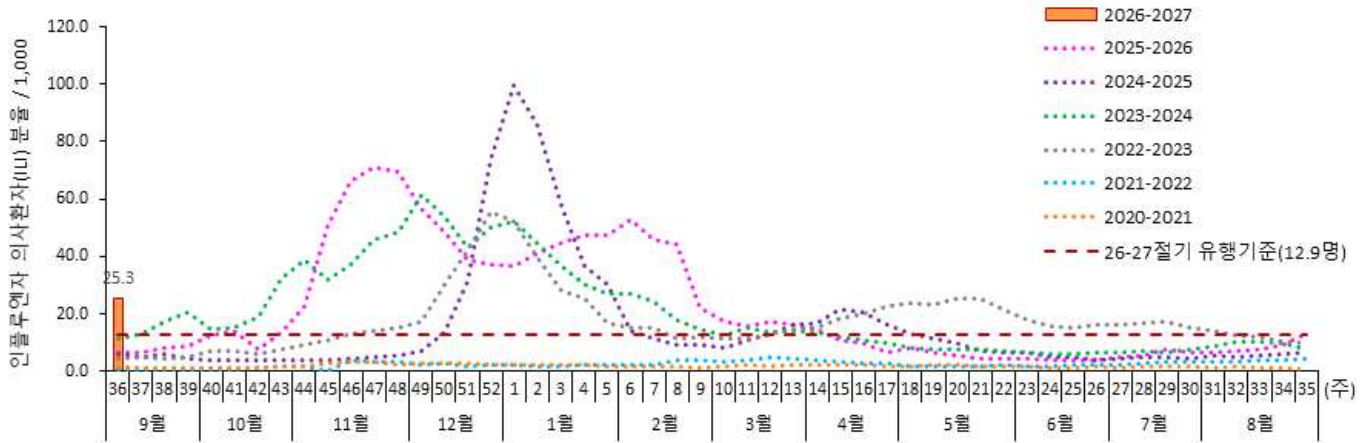


그림 1. 외래환자 1,000명당 인플루엔자 의사환자 발생 현황

2. 수족구병 발생 주간 현황(37주차, 2026. 9. 12. 기준)

- 외래환자 1,000명당 의사환자분율: 15.0명
- 변동(주간): 2026년 35주차(18.6명) 대비 감소
- 표본보고기관: 전국 92개 의료기관

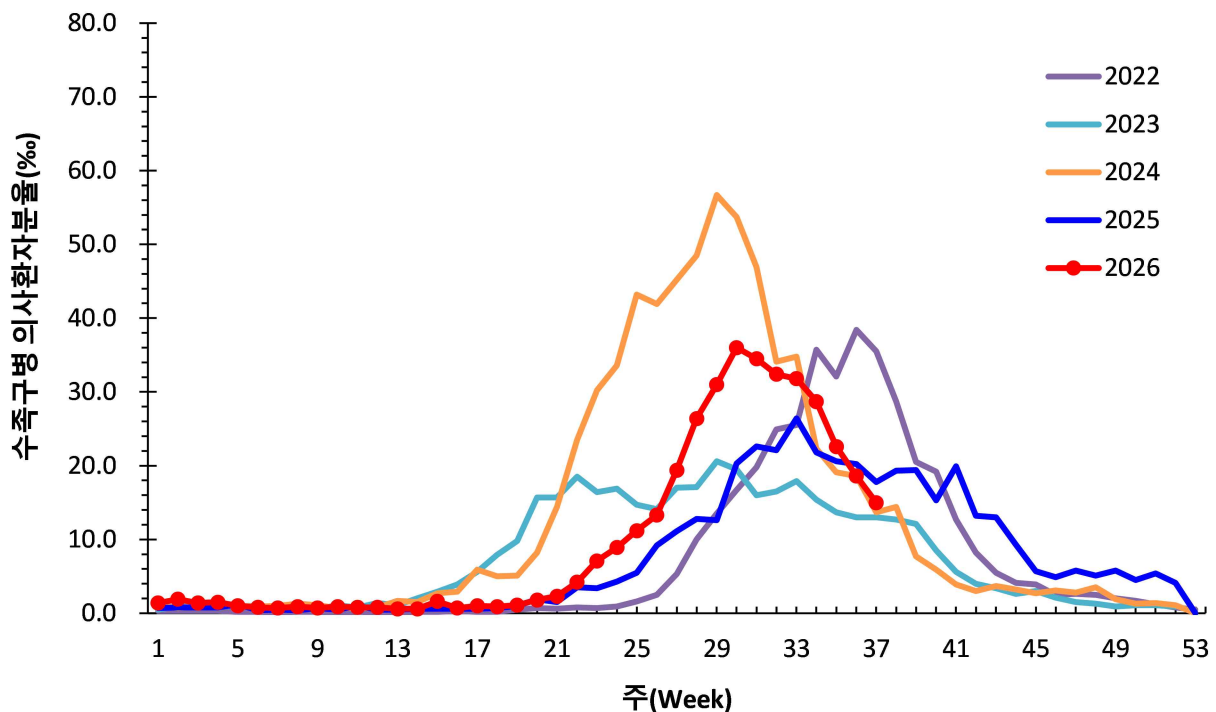


그림 2. 외래환자 1,000명당 수족구병 의사환자 발생 현황, 2022-2026

3. 안과 감염병 주간 발생 현황(36주차, 2026. 9. 5. 기준)

- 외래환자 1,000명당 유행성각결막염 의사환자분율: 10.1명
- 변동(주간): 2026년 35주차(8.4명) 대비 증가
- 표본보고기관: 전국 77개 의료기관

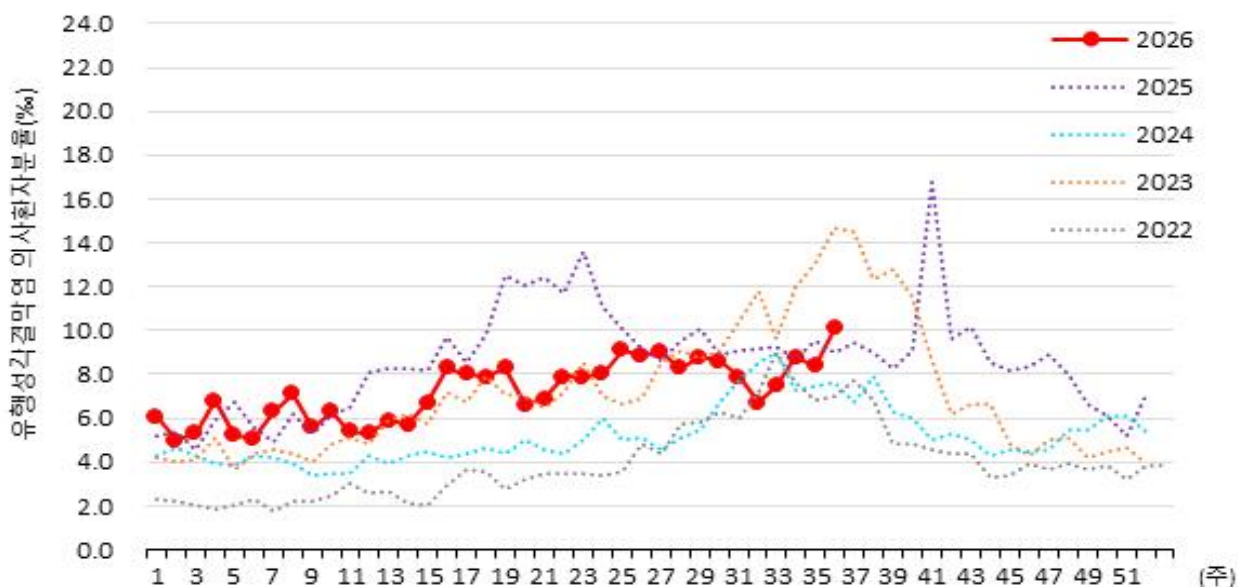


그림 3. 외래환자 1,000명당 유행성각결막염 의사환자 발생 현황, 2022-2026

- 외래환자 1,000명당 급성출혈성결막염 의사환자분율: 0.6명
- 변동(주간): 2026년 35주차(0.7명) 대비 감소
- 표본보고기관: 전국 77개 의료기관

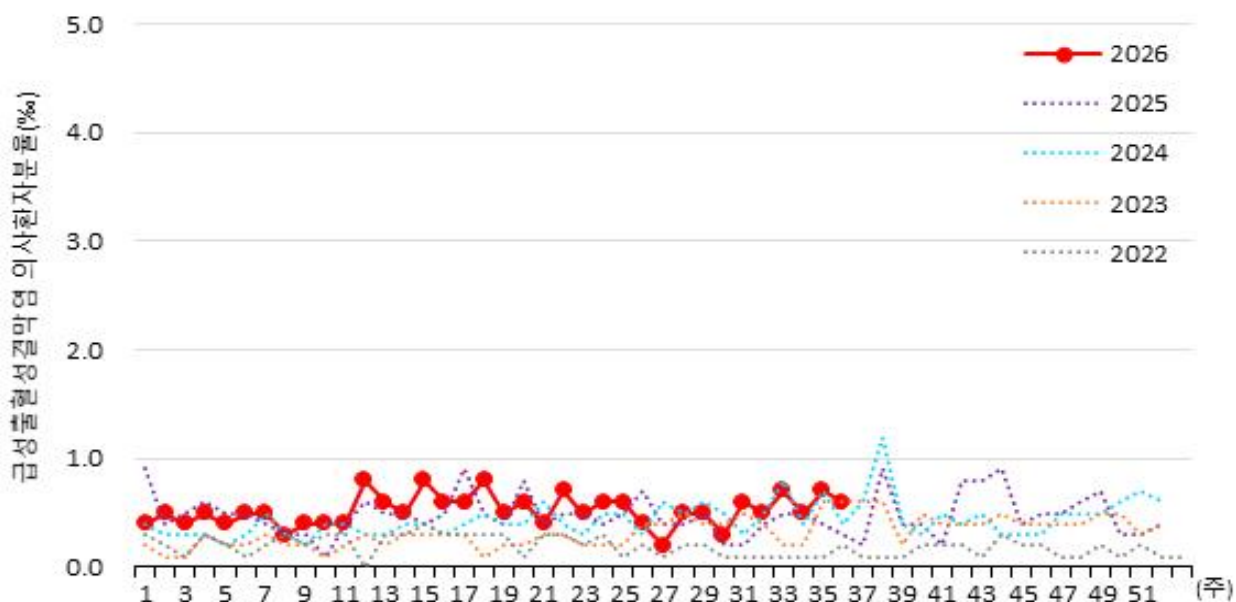


그림 4. 외래환자 1,000명당 급성출혈성결막염 의사환자 발생 현황, 2022-2026

4. 성매개감염병 주간 발생 현황(37주차, 2026. 9. 12. 기준)

- 보고기관당 환자수: 사람유두종바이러스 감염증 3.8건, 성기단순포진 2.4건, 클라미디아 감염증 1.4건, 첨규콘딜롬 1.3건, 임질 1.0건을 신고함
- 변동(주간)
증가: 사람유두종바이러스 감염증(3.3→3.8), 클라미디아 감염증(1.3→1.4)
감소: 성기단순포진(2.5→2.4), 첨규콘딜롬(1.7→1.3), 임질(1.3→1.0)
- 표본보고기관: 전국 보건소 및 의료기관 560
- * 제37주차 신고의료기관 수: 임질 18개, 클라미디아 감염증 72개, 성기단순포진 78개, 첨규콘딜롬 30개, 사람유두종바이러스 감염증 78개

단위 : 신고수/신고기관 수

임질			클라미디아 감염증			성기단순포진		
금주	2026년 누적	최근 5년 누적 평균 [§]	금주	2026년 누적	최근 5년 누적 평균 [§]	금주	2026년 누적	최근 5년 누적 평균 [§]
1.0	3.1	5.1	1.4	12.5	17.5	2.4	40.1	38.7

첨규콘딜롬			사람유두종바이러스 감염증		
금주	2026년 누적	최근 5년 누적 평균 [§]	금주	2026년 누적	최근 5년 누적 평균 [§]
1.3	12.1	15.3	3.8	72.8	73.1

누계 : 매년 첫 주부터 금주까지의 보고 누계

† 각 질병별로 규정된 신고 범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함

§ 최근 5년('21~'25) 누적 평균(Cum. 5-year average) : 최근 5년 1주차부터 금주까지 누적 환자 수 평균

III. 수인성 및 식품매개 감염병 주간 발생 현황

1. 수인성 및 식품매개 감염병 집단발생 주간 현황(37주차, 2026. 9. 12. 기준)

- 수인성 및 식품매개 감염병 집단발생: 12건, 93명(금년 누적 발생: 574건, 14,000명)
- 변동(주간): 2026년 36주차(13건) 대비 감소

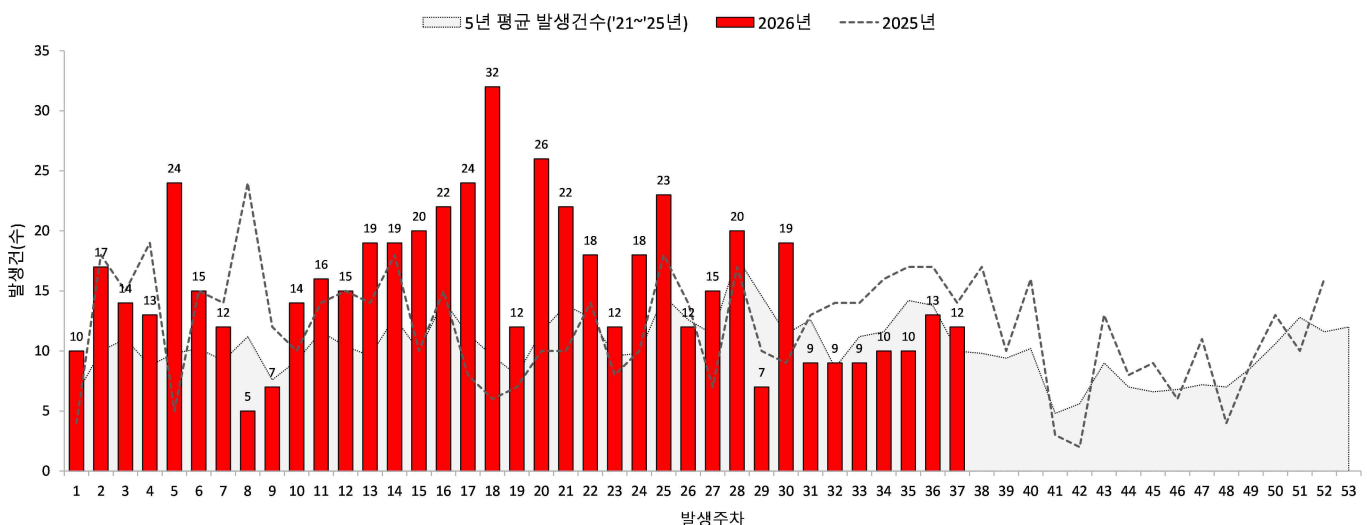


그림 5. 수인성 및 식품매개 감염병 집단발생 현황, 2025-2026

IV. 병원체감시 : 인플루엔자 및 호흡기바이러스

1. 인플루엔자 바이러스 주간 현황(37주차, 2026. 9. 12. 기준)

- 인플루엔자 양성률: 24.6%
[인플루엔자 아형: A(H1N1)pdm09 24.2%, A(H3N2) 0.2%, B 0.2%]
- 변동(주간): 2026년 36주차(16.3%) 대비 증가
- 표본보고기관: 109개 의료기관

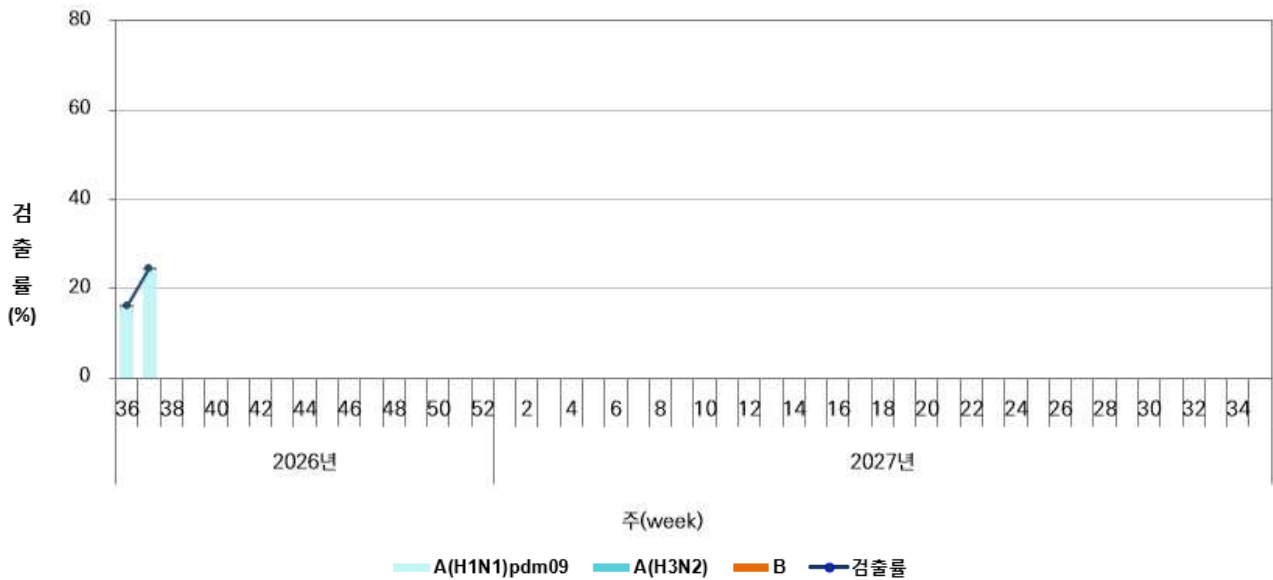


그림 6. 인플루엔자 바이러스 검출 현황, 2026-2027절기

2. 호흡기 바이러스 주간 현황(37주차, 2026. 9. 12. 기준)

- 호흡기바이러스 양성률: 71.1%(금주 및 최근 3주 누적 분율: 66.2%)
- 변동(주간): 2026년 36주차(65.5%) 대비 증가
- 표본보고기관: 18개 시·도 보건환경연구원 및 106개 의료기관

※ 주별통계는 잠정통계이므로 변동가능

주		주별	검출률 (%)								
		검출률 (%)	아데노 바이러스	보카 바이러스	파라 인플루엔자 바이러스	호흡기 세포융합 바이러스	리노 바이러스	메타뉴모 바이러스	코로나 바이러스	인플루엔자 바이러스	코로나19 바이러스
2026	34	59.7	3.2	2.3	14.0	2.3	12.7	3.6	0.5	10.0	11.3
	35	64.1	3.9	2.2	11.7	1.1	17.3	3.9	0.0	12.3	11.7
	36	65.5	2.4	1.7	10.3	0.9	13.3	3.4	0.9	16.3	16.3
	37	71.1	3.3	1.8	7.7	0.8	15.7	2.0	1.0	24.6	14.2
4주 누적※		66.2	3.2	1.9	10.3	1.1	14.9	3.1	0.6	17.2	13.8
2026년 누적▽		76.5	3.6	3.4	11.0	5.3	16.8	7.1	9.4	15.8	4.2

※ 4주 누적 : 2026년 8월 16일 - 2026년 9월 12일 검출률임

▽ 2026년 누적 : 2025년 12월 28일 - 2026년 9월 12일 검출률임

V. 병원체감시 : 급성설사질환 바이러스 및 세균

1. 급성설사 바이러스 주간 검출 현황(36주차, 2026. 9. 5. 기준)

- 급성설사 바이러스 검출률: 19.2% (14 양성 / 73 검체) [2026년 누적분율: 40.2% (1,151건 양성 / 2,860 검체)]
- 변동(주간): 2026년 35주차(20.5%) 대비 감소
- 표본보고기관: 18개 시·도 보건환경연구원 및 72개 의료기관

주	검체수	검출 건수(검출률, %)											
		노로바이러스		그룹 A 로타바이러스		장내 아데노바이러스		아스트로 바이러스		사포 바이러스		합계	
2026	33	67	2 (3.0)	0 (0.0)	3 (4.5)	1 (1.5)	3 (4.5)	9 (13.4)					
	34	66	1 (1.5)	0 (0.0)	6 (9.1)	0 (0.0)	3 (4.5)	10 (15.2)					
	35	73	2 (2.7)	0 (0.0)	6 (8.2)	2 (2.7)	5 (6.8)	15 (20.5)					
	36	73	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (8.2)	3 (4.1)	5 (6.8)	14 (19.2)					
2026년 누적		2,860	827 (28.9)	102 (3.6)	125 (4.4)	62 (2.2)	35 (1.2)	1,151 (40.2)					

* 검체는 5세 이하 아동의 급성설사질환자에게서 수집됨.

2. 급성설사 세균 주간 검출 현황(36주차, 2026. 9. 5. 기준)

- 급성설사 세균 검출률: 24.2% (50건 양성 / 207 검체) [2026년 누적분율: 14.0% (1,450건 양성 / 10,346 검체)]
- 변동(주간): 2026년 35주차(23.5%) 대비 증가
- 표본보고기관: 18개 시·도 보건환경연구원 및 76개 의료기관

주		검체수	분리 건수 (분리율, %)									
			살모넬라균	병원성 대장균	세균성 이질균	장염 비브리오균	비브리오 콜레라균	캠필로 박터균	클로스 트리움 퍼프린젠스	황색 포도알균	바실루스 세레우스	합계
2026	33	251	21 (8.4)	21 (8.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.8)	10 (4.0)	5 (2.0)	59 (23.5)
	34	286	19 (6.6)	45 (15.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (1.0)	5 (1.7)	12 (4.2)	8 (2.8)	92 (32.2)
	35	247	19 (7.7)	19 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	2 (0.8)	11 (4.5)	5 (2.0)	58 (23.5)
	36	207	14 (6.8)	23 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	7 (3.4)	5 (2.4)	50 (24.2)
2026년 누적		10,346	280 (2.7)	421 (4.1)	0 (0.0)	1 (0.01)	0 (0.0)	96 (0.9)	206 (2.0)	225 (2.2)	207 (2.0)	1,450 (14.0)

VI. 병원체감시 : 엔테로바이러스

1. 엔테로바이러스 주간 검출 현황(36주차, 2026. 9. 5. 기준)

- 엔테로바이러스 검출률: 59.4% (19 양성 / 32 검체) [2026년 누적분율: 42.4% (386건 양성 / 911 검체)]
 - 무균성수막염: 0건(2026년 누계: 3건)
 - 수족구병 및 포진성구협염: 14건(2026년 누계: 248건)
 - 합병증 동반 수족구병: 0건(2026년 누계: 5건)
 - 기타: 5건(2026년 누계: 130건)
- 변동(주간): 2026년 35주차(48.6%) 대비 증가
- 표본보고기관: 18개 시·도 보건환경연구원 및 83개 의료기관



그림 7. 무균성수막염에서 엔테로바이러스 검출건수, 2024-2026

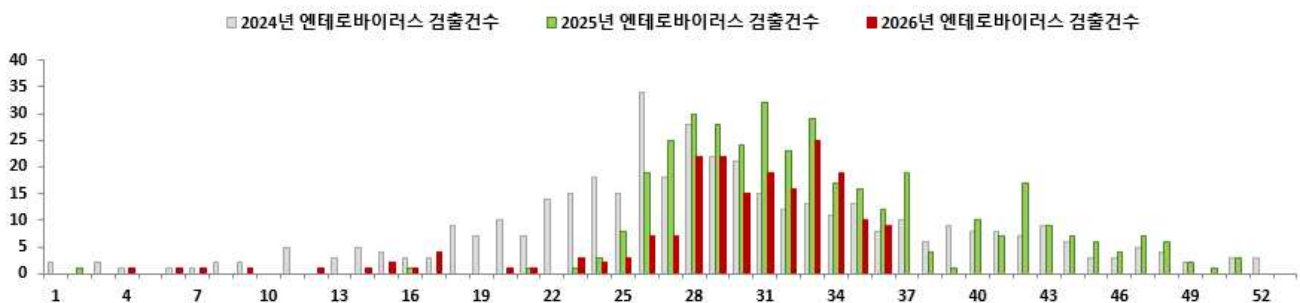


그림 8. 수족구병 및 포진성구협염에서 엔테로바이러스 검출건수, 2024-2026



그림 9. 합병증 동반 수족구병에서 엔테로바이러스 검출건수, 2024-2026

VII. 매개체감시 : 말라리아 매개모기

1. 말라리아 매개모기 주간 검출 현황(36주차, 2026. 9. 5. 기준)

- 말라리아 매개모기 검출수: 3.2개체
- 변동: 평년 3.8개체 대비 감소, 전년 5.0개체 대비 감소
 - * 전체 채집 모기 5,052개체 중 말라리아 매개모기는 1,102개체가 채집됨
- 표본보고기관: 4개 시·도(88개 지점)
 - ※ 모기수 산출법(모기지수): 1주일간 유문등에 채집된 모기의 평균수(개체수/트랩/일)
 - ※ 평년: 최근 3년(2023-2025년)의 평균값

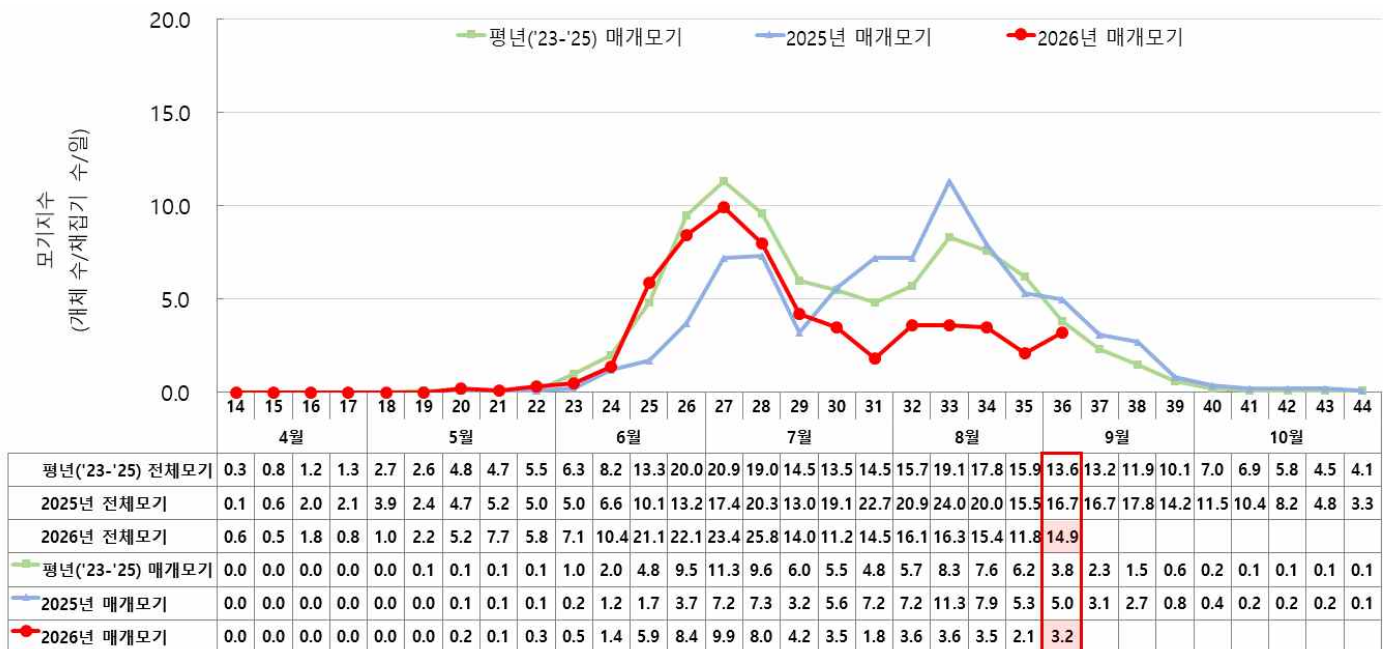


그림 10. 말라리아 매개모기 주간 발생 현황

※ 27주차 채집지점에서 발생한 채집 모기 개체 손실을 보정함

VIII. 매개체감시 : 일본뇌염 매개모기

1. 일본뇌염 매개모기 주간 검출 현황(37주차, 2026. 9. 12. 기준)

- 일본뇌염 매개모기 검출수: 77개체(Japanese encephalitis vector, JEV)
- 변동: 평년 304개체 대비 감소, 전년 301개체 대비 감소
- 표본보고기관: 12개 시·도 보건환경연구원(부산, 대구, 울산, 강원, 충북, 충남, 세종, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주 / 14개 지점)
 ※ 모기수 산출법(모기지수): 유문등에 채집된 모기의 평균수(모기수/트랩/일)
 ※ 평년: 최근 3년(2023-2025년)의 평균값

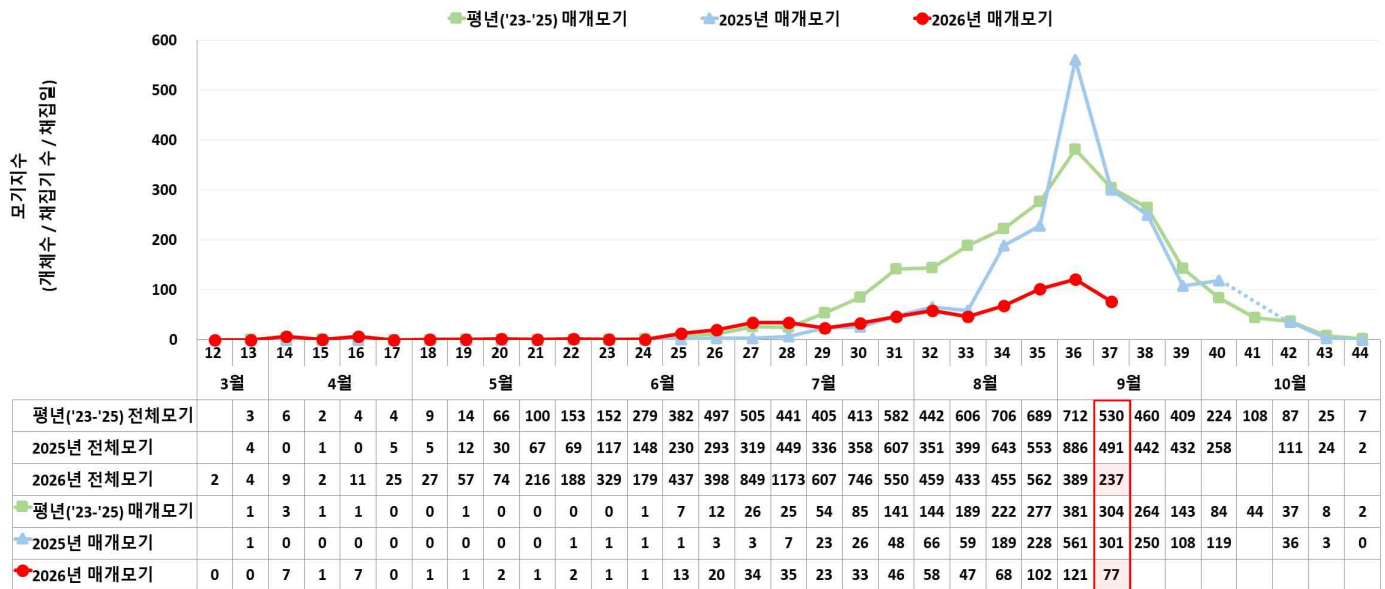


그림 11. 일본뇌염 매개모기 주간 발생 현황

- ※ 추석연휴로 인하여 2025년 41주차 일본뇌염 감시 사업 매개체 채집 미수행
- ※ 2026년 감시사업 기간 확대에 의한 12주차 매개체 채집 첫 수행

IX. 매개체감시 : 쯔쯔가무시증 매개털진드기

1. 쯔쯔가무시증 매개털진드기 주간 검출 현황(37주차, 2026. 9. 12. 기준)

- 쯔쯔가무시증 매개털진드기 트랩지수: 0.00
- 변동: 평년(0.01) 대비 감소, 전년(0.00) 대비 동일
- 표본보고기관: 9개 시·도(18개 지점)
 - ※ 트랩지수: 18개 지점에서 주차별 채집된 털진드기의 수를 트랩당 개체수(개체수/채집기 수)로 산출
 - ※ 평년: 최근 3년(2023-2025년)
 - '18년은 37~48주차, '19년은 37~50주차, '20년부터 감시기간 확대하여 36~51주차 기간 동안 운영
 - '26년은 총 18개 지점, 총 360개 채집기(지점당 20개) 운영



그림 12. 쯔쯔가무시증 매개털진드기 검출수

주요 통계 이해하기

<통계표 1>은 지난 5년간 발생한 법정감염병과 2024년 해당 주 발생현황을 비교한 표로, **금주 환자 수(Current week)**는 2025년 해당주의 신고 건수를 나타내며, **2025년 누계 환자 수(Cum. 2025)**는 2025년 1주부터 해당 주까지의 누계 건수, 그리고 **5년 주 평균 환자 수(5-year weekly average)**는 지난 5년(2020-2024년) 해당 주의 신고 건수와 이전 2주, 이후 2주의 신고 건수(총 25주) 평균으로 계산된다. 그러므로 금주 환자 수(Current week)와 5년 주 평균 환자 수(5-year weekly average)의 신고 건수를 비교하면 해당 주 단위 시점과 예년의 신고 수준을 비교해 볼 수 있다. 연도별 환자 수(Total no. of cases by year)는 지난 5년간 해당 감염병 현황을 나타내는 확정 통계이며 연도별 현황을 비교해 볼 수 있다.

예) 2024년 12주의 5년 주 평균 환자 수(5-year weekly average)는 2020년부터 2024년의 10주부터 14주까지의 신고 건수를 총 25주로 나눈 값으로 구해진다.

$$* 5년 주 평균 환자 수(5-year weekly average) = (X1 + X2 + \dots + X25) / 25$$

	10주	11주	12주	13주	14주
2025년			해당 주		
2024년	X1	X2	X3	X4	X5
2023년	X6	X7	X8	X9	X10
2022년	X11	X12	X13	X14	X15
2021년	X16	X17	X18	X19	X20
2020년	X21	X22	X23	X24	X25

<통계표 2>는 17개 시도 별로 구분한 법정감염병 보고 현황을 보여 주고 있으며, 감염병별로 최근 5년 누계 평균 환자 수(Cum, 5-year average)와 2025년 누계 환자 수(Cum, 2025)를 비교해 보면 최근까지의 누적 신고 건수에 대한 이전 5년 동안 해당 주까지의 평균 신고 건수와 비교를 할 수 있다. 최근 5년 누계 평균 환자 수(Cum, 5-year average)는 지난 5년(2020-2024년) 동안의 동 기간 신고 누계 평균으로 계산된다.

기타 표본감시 감염병에 대한 신고현황 그림과 통계는 최근 발생양상을 신속하게 파악하는 데 도움이 된다.

Vol. 19, No. 36, September 17, 2026

I. National Notifiable Infectious Diseases

1. Reported cases, week ending September 12, 2026 (37th Week)

Unit: no. of cases[†]

Classification of disease [‡]	Current week [*]	Cum. 2026 [*]	5-year weekly average	Total no. of cases by year					Imported cases of current week : Country (no. of cases)
				2025	2024	2023	2022	2021	
Category II									
Tuberculosis**	366	12,518	345	17,070	17,944	19,540	20,383	22,904	
Varicella	283	23,567	344	30,248	31,892	26,964	18,547	20,929	Philippines(1)
Measles	0	10	0	78	49	8	0	0	
Cholera	0	0	0	0	0	0	0	0	
Typhoid fever	1	16	1	33	34	19	38	61	
Paratyphoid fever	0	6	1	24	23	22	31	29	
Shigellosis	0	30	1	64	41	37	31	18	
EHEC	0	466	7	531	274	216	211	165	
Viral hepatitis A	27	1,247	44	1,141	1,168	1,324	1,890	6,583	United States of America(1)
Pertussis	1	291	175	5,491	48,048	292	31	21	
Mumps	87	3,912	126	6,720	6,425	7,737	6,358	9,708	
Rubella	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meningococcal disease	0	7	0	12	17	11	3	2	
Pneumococcal disease	4	306	5	440	451	431	339	269	
Hansen's disease	0	5	0	3	5	3	2	5	
Scarlet fever	82	8,686	74	13,113	6,642	815	505	678	
VRSA	0	2	0	2	1	2	1	3	
CRE	1,139	39,783	813	49,053	42,345	38,405	30,543	23,310	
Viral hepatitis E	6	524	14	915	756	572	528	494	
Category III									
Tetanus	2	15	1	24	29	24	23	21	
Viral hepatitis B	2	161	6	315	315	315	332	453	
Japanese encephalitis	0	1	1	7	21	17	11	23	
Viral hepatitis C	67	3,659	131	5,639	6,444	7,249	8,308	10,116	
Malaria	9	303	18	601	713	747	420	294	
Legionellosis	9	549	11	640	452	476	415	383	
<i>Vibrio vulnificus</i> sepsis	1	21	4	68	49	69	46	52	
Murine typhus	0	3	0	16	60	21	4	9	
Scrub typhus	3	135	23	3,405	6,268	5,663	6,235	5,915	
Leptospirosis	0	18	2	53	70	59	125	144	
Brucellosis	0	2	0	4	5	5	5	4	
HFRS	2	85	5	230	373	452	302	310	
HIV/AIDS***									
CJD	0	38	1	99	67	67	61	68	
Dengue fever	9	62	3	110	196	206	103	3	Maldives(2), Vietnam(5), Indonesia(1), Thailand [China Vietnam Laos(1)]
Q fever	1	78	2	72	57	57	56	46	
Lyme Borreliosis	0	27	1	41	34	45	22	8	
Melioidosis	0	2	0	5	2	2	2	2	
Chikungunya fever	0	6	0	9	9	13	8	0	
SFTS	1	97	6	280	170	198	193	172	
Zika virus infection	0	3	0	3	0	2	3	0	
MPOX(Monkeypox)	1	13	-	27	17	151	4	-	
Syphilis	33	1,379	-	2,211	2,790	-	-	-	
Primary syphilis	16	504	-	721	983	-	-	-	Thailand(2), Vietnam(1)
Secondary syphilis	8	290	-	449	524	-	-	-	
Tertiary syphilis	0	44	-	50	51	-	-	-	
Congenital syphilis	0	8	-	12	12	-	-	-	
Latent syphilis	18	639	-	979	1,220	-	-	-	

Abbreviation: EHEC= Enterohemorrhagic *Escherichia coli*; VRSA= Vancomycin-resistant *Staphylococcus aureus*; CRE= Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae; HFRS= Hemorrhagic fever with renal syndrome; CJD= Creutzfeldt-Jacob Disease; SFTS= Severe fever with thrombocytopenia syndrome.

Cum: Cumulative counts from 1st week to current week in a year.

* The reported data for year 2026 is provisional, whereas data from 2021 to 2025 are finalized.

** The number of tuberculosis cases has been changed to total cases(new patient, previously treated patient(relapse patient, treatment after failure patient, treatment after loss to follow-up patient, other previously treated patient), patient with previous tuberculosis treatment history) since 2025.

*** The number of HIV/AIDS cases excluded those who have no Korean citizenship.

† The reported cases contain all case classifications such as confirmed, suspected, and asymptomatic carrier of the disease.

‡ The reported surveillance data excluded no incidence data such as Ebola virus disease, Marburg, Hemorrhagic fever, Lassa fever, Crimean Congo Hemorrhagic fever, South American Hemorrhagic fever, Rift Valley fever, Smallpox, Plague, Anthrax, Botulism, Tularemia, Newly emerging infectious disease syndrome, Severe Acute Respiratory Syndrome, Middle East Respiratory Syndrome, Human infection with zoonotic influenza, Novel Influenza, Diphtheria, Nipah virus infection, Poliomyelitis, *Haemophilus influenza* type b, Epidemic typhus, Rabies, Yellow fever, West Nile fever and Tick-borne Encephalitis.

2. Reported cases by geography, week ending September 12, 2026 (37th Week)*

Unit: no. of cases[†]

Reporting area	Diseases of Category II											
	Tuberculosis**			Varicella			Measles			Cholera		
	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]
Overall	366	12,518	13,493	283	23,567	17,992	0	10	0	0	0	0
Seoul	58	2,034	2,246	43	3,047	2,168	0	3	0	0	0	0
Jeonnam Gwangju [‡]	32	997	1,057	19	1,561	1,414	0	0	0	0	0	0
Busan	29	800	863	17	1,238	1,038	0	0	0	0	0	0
Daegu	14	570	638	12	1,136	1,034	0	0	0	0	0	0
Incheon	21	695	717	16	904	801	0	1	0	0	0	0
Daejeon	11	321	297	11	448	456	0	0	0	0	0	0
Ulsan	6	234	251	3	571	460	0	0	0	0	0	0
Sejong	1	50	59	1	295	170	0	0	0	0	0	0
Gyeonggi	75	2,792	2,996	97	7,105	5,077	0	3	0	0	0	0
Gangwon	14	505	563	5	620	570	0	0	0	0	0	0
Chungbuk	10	399	451	11	595	624	0	1	0	0	0	0
Chungnam	20	681	709	15	1,000	649	0	1	0	0	0	0
Jeonbuk	10	523	561	14	1,222	619	0	1	0	0	0	0
Gyeongbuk	30	964	1,057	0	1,232	950	0	0	0	0	0	0
Gyeongnam	25	790	859	16	1,952	1,455	0	0	0	0	0	0
Jeju	10	163	168	3	641	507	0	0	0	0	0	0

Cum: Cumulative counts from 1st week to current week in a year

* The reported data for year 2026 is provisional, whereas data from 2021 to 2025 are finalized.

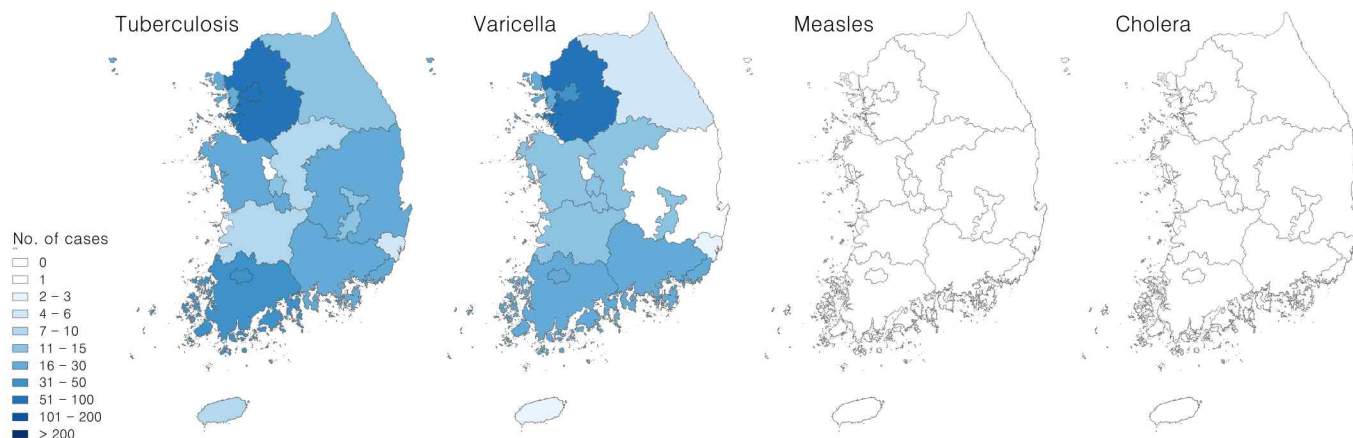
** The number of tuberculosis cases has been changed to total cases(new patient, previously treated patient(relapse patient, treatment after failure patient, treatment after loss to follow-up patient, other previously treated patient), patient with previous tuberculosis treatment history) since 2025.

† The reported cases contain all case classifications such as confirmed, suspected, and asymptomatic carrier of the disease.

§ Cum. 5-year average is mean value calculated by cumulative counts from 1st week to current week for 5 preceding years.

‡ Gwangju Metropolitan City and Jeollanam-do were integrated into Jeonnam-Gwangju Special Metropolitan City from July 2026 due to the reorganization of the local administrative system, and the cumulative statistics of Jeonnam-Gwangju included the reported cases of Gwangju, Jeollanam-do, and Jeonnam-Gwangju.

※ Weekly reported cases of notifiable diseases, by geography



2. (Continued) Reported cases by geography, week ending September 12, 2026 (37th Week)*

Unit: no. of cases[†]

Reporting area	Diseases of Category II											
	Typhoid fever			Paratyphoid fever			Shigellosis			Enterohemorrhagic <i>Escherichia coli</i>		
	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]
Overall	1	16	27	0	6	16	0	30	30	0	466	214
Seoul	0	2	4	0	1	3	0	11	4	0	70	33
Jeonnam Gwangju [‡]	0	2	2	0	1	2	0	0	3	0	72	38
Busan	1	2	3	0	0	2	0	3	2	0	20	6
Daegu	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	21	10
Incheon	0	0	1	0	1	1	0	3	2	0	32	11
Daejeon	0	0	1	0	1	0	0	2	3	0	21	7
Ulsan	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	8	3
Sejong	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	2
Gyeonggi	0	6	6	0	0	5	0	9	8	0	96	49
Gangwon	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	6
Chungbuk	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5
Chungnam	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	32	9
Jeonbuk	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	19	6
Gyeongbuk	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	25	13
Gyeongnam	0	2	3	0	0	1	0	1	1	0	21	11
Jeju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5

Cum: Cumulative counts from 1st week to current week in a year

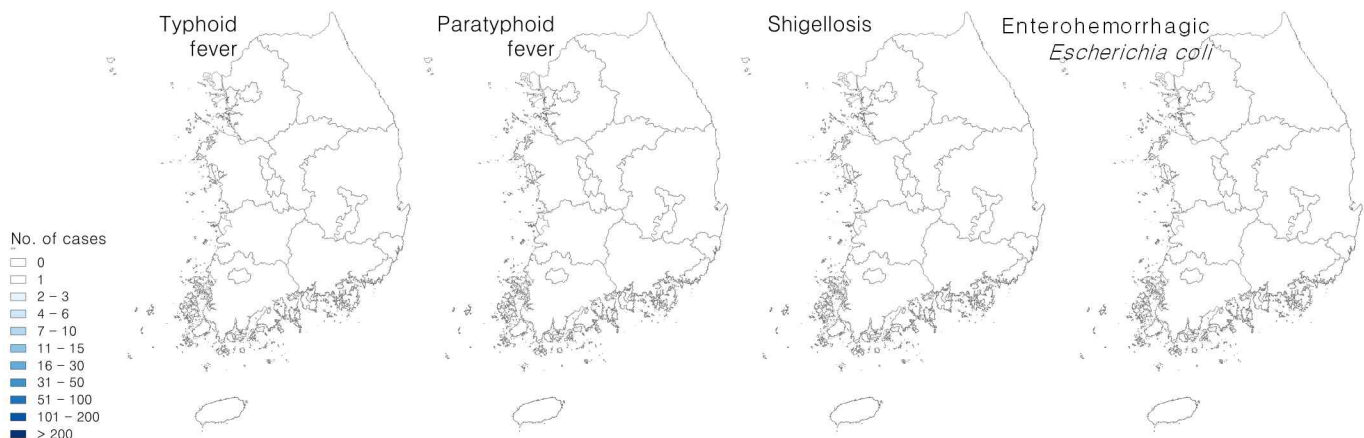
* The reported data for year 2026 is provisional, whereas data from 2021 to 2025 are finalized.

† The reported cases contain all case classifications such as confirmed, suspected, and asymptomatic carrier of the disease.

§ Cum. 5-year average is mean value calculated by cumulative counts from 1st week to current week for 5 preceding years.

‡ Gwangju Metropolitan City and Jeollanam-do were integrated into Jeonnam-Gwangju Special Metropolitan City from July 2026 due to the reorganization of the local administrative system, and the cumulative statistics of Jeonnam-Gwangju included the reported cases of Gwangju, Jeollanam-do, and Jeonnam-Gwangju.

※ Weekly reported cases of notifiable diseases, by geography



2. (Continued) Reported cases by geography, week ending September 12, 2026 (37th Week)*

Unit: no. of cases[†]

Reporting area	Diseases of Category II											
	Viral hepatitis A			Pertussis			Mumps			Rubella		
	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]
Overall	27	1,247	1,817	1	291	5,470	87	3,912	5,369	0	0	0
Seoul	2	205	362	0	29	682	15	540	707	0	0	0
Jeonnam Gwangju [‡]	2	64	81	0	18	319	4	265	393	0	0	0
Busan	0	22	48	1	28	283	4	179	252	0	0	0
Daegu	1	30	41	0	8	158	6	207	257	0	0	0
Incheon	1	130	136	0	34	603	5	216	287	0	0	0
Daejeon	0	28	53	0	9	160	3	106	144	0	0	0
Ulsan	0	12	15	0	12	61	4	123	186	0	0	0
Sejong	0	9	12	0	7	57	1	24	44	0	0	0
Gyeonggi	15	396	645	0	58	1,579	32	1,175	1,595	0	0	0
Gangwon	0	22	43	0	5	109	5	159	206	0	0	0
Chungbuk	0	41	73	0	5	114	2	92	154	0	0	0
Chungnam	3	67	111	0	6	141	1	197	259	0	0	0
Jeonbuk	1	128	81	0	5	180	5	131	190	0	0	0
Gyeongbuk	0	50	48	0	10	245	0	135	217	0	0	0
Gyeongnam	0	21	33	0	55	623	0	302	387	0	0	0
Jeju	2	22	35	0	2	156	0	61	91	0	0	0

Cum: Cumulative counts from 1st week to current week in a year

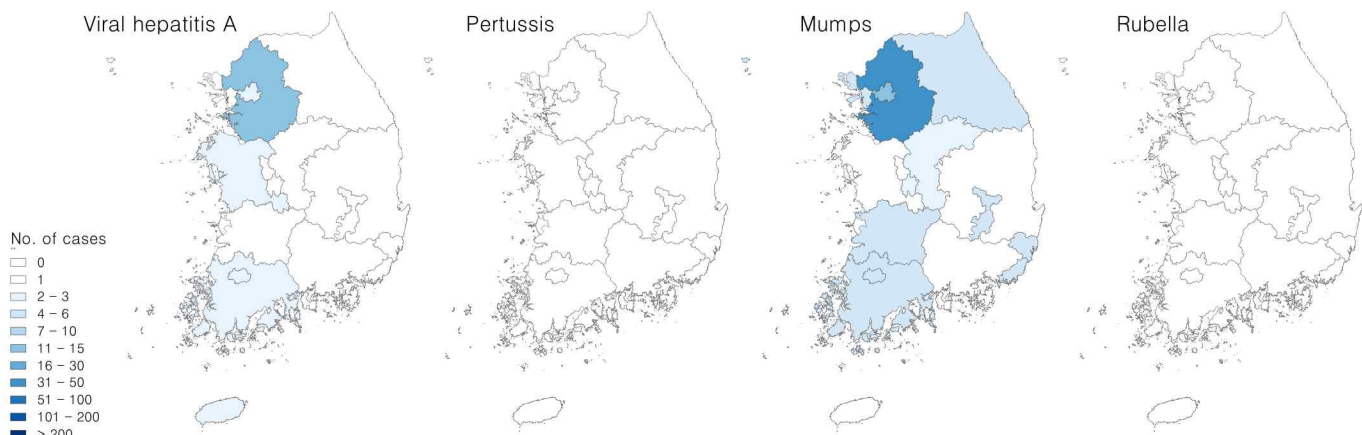
* The reported data for year 2026 is provisional, whereas data from 2021 to 2025 are finalized.

† The reported cases contain all case classifications such as confirmed, suspected, and asymptomatic carrier of the disease.

§ Cum. 5-year average is mean value calculated by cumulative counts from 1st week to current week for 5 preceding years.

‡ Gwangju Metropolitan City and Jeollanam-do were integrated into Jeonnam-Gwangju Special Metropolitan City from July 2026 due to the reorganization of the local administrative system, and the cumulative statistics of Jeonnam-Gwangju included the reported cases of Gwangju, Jeollanam-do, and Jeonnam-Gwangju.

※ Weekly reported cases of notifiable diseases, by geography



2. (Continued) Reported cases by geography, week ending September 12, 2026 (37th Week)*

Unit: no. of cases[†]

Reporting area	Diseases of Category II						Diseases of Category III					
	Meningococcal disease			Scarlet fever			Tetanus			Viral hepatitis B		
	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]
Overall	0	7	5	82	8,686	3,070	2	15	17	2	161	230
Seoul	0	1	2	11	1,140	439	0	0	2	1	34	35
Jeonnam Gwangju [‡]	0	0	0	8	609	170	0	3	0	0	20	15
Busan	0	0	0	2	802	167	0	1	1	0	8	14
Daegu	0	1	0	1	360	56	0	1	1	0	7	8
Incheon	0	2	0	8	899	286	0	0	2	0	8	15
Daejeon	0	0	0	1	285	77	0	0	0	0	5	6
Ulsan	0	0	0	2	251	53	0	0	0	0	2	3
Sejong	0	0	0	0	66	13	0	0	0	0	1	1
Gyeonggi	0	2	3	35	2,615	986	0	2	3	1	38	69
Gangwon	0	0	0	1	131	127	0	0	1	0	4	7
Chungbuk	0	0	0	1	183	91	1	2	1	0	7	7
Chungnam	0	0	0	5	452	155	1	3	2	0	4	15
Jeonbuk	0	0	0	5	139	44	0	1	1	0	4	9
Gyeongbuk	0	0	0	2	175	158	0	2	1	0	6	9
Gyeongnam	0	0	0	0	513	217	0	0	2	0	10	14
Jeju	0	1	0	0	66	31	0	0	0	0	3	3

Cum: Cumulative counts from 1st week to current week in a year

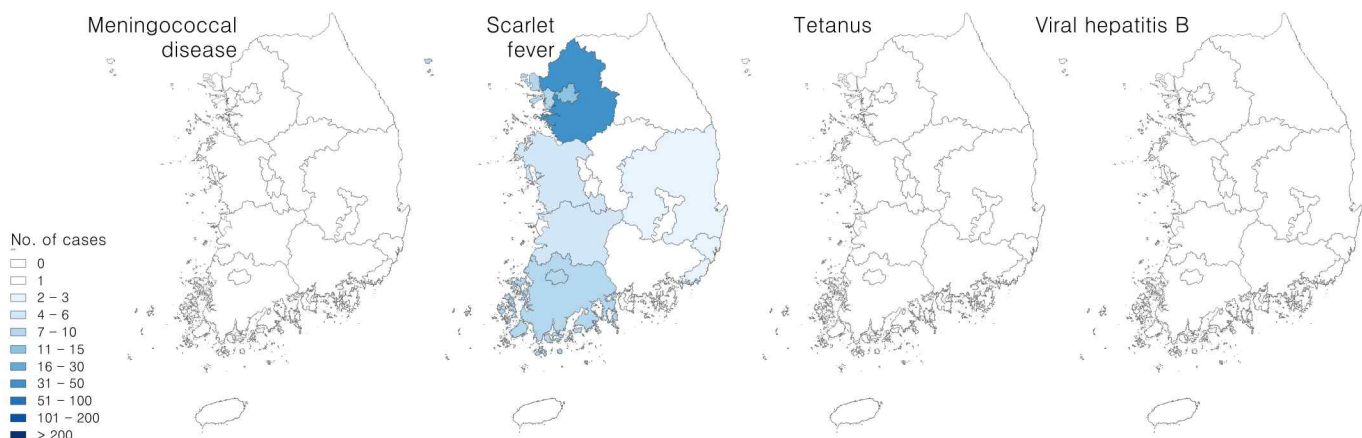
* The reported data for year 2026 is provisional, whereas data from 2021 to 2025 are finalized.

† The reported cases contain all case classifications such as confirmed, suspected, and asymptomatic carrier of the disease.

§ Cum. 5-year average is mean value calculated by cumulative counts from 1st week to current week for 5 preceding years.

‡ Gwangju Metropolitan City and Jeollanam-do were integrated into Jeonnam-Gwangju Special Metropolitan City from July 2026 due to the reorganization of the local administrative system, and the cumulative statistics of Jeonnam-Gwangju included the reported cases of Gwangju, Jeollanam-do, and Jeonnam-Gwangju.

✂ Weekly reported cases of notifiable diseases, by geography



2. (Continued) Reported cases by geography, week ending September 12, 2026 (37th Week)*

Unit: no. of cases[†]

Reporting area	Diseases of Category III											
	Japanese encephalitis			Malaria			Legionellosis			<i>Vibrio vulnificus</i> sepsis		
	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]
Overall	0	1	1	9	303	458	9	549	321	1	21	30
Seoul	0	0	0	1	36	58	2	155	68	0	1	4
Jeonnam Gwangju [‡]	0	0	0	0	4	9	0	18	20	0	4	6
Busan	0	0	0	0	3	6	0	18	12	0	4	2
Daegu	0	0	0	0	3	3	0	34	19	0	0	0
Incheon	0	0	0	2	50	75	1	33	23	0	0	2
Daejeon	0	0	0	0	3	4	1	12	7	0	0	1
Ulsan	0	0	0	0	1	3	1	9	2	0	0	0
Sejong	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0
Gyeonggi	0	1	0	5	168	261	3	147	86	0	3	6
Gangwon	0	0	0	1	21	20	0	19	6	0	1	0
Chungbuk	0	0	0	0	3	3	0	12	8	0	0	0
Chungnam	0	0	0	0	2	5	0	14	8	0	2	2
Jeonbuk	0	0	0	0	2	2	0	15	7	1	3	0
Gyeongbuk	0	0	0	0	4	4	1	23	18	0	0	2
Gyeongnam	0	0	1	0	2	3	0	24	17	0	3	5
Jeju	0	0	0	0	1	1	0	13	19	0	0	0

Cum: Cumulative counts from 1st week to current week in a year

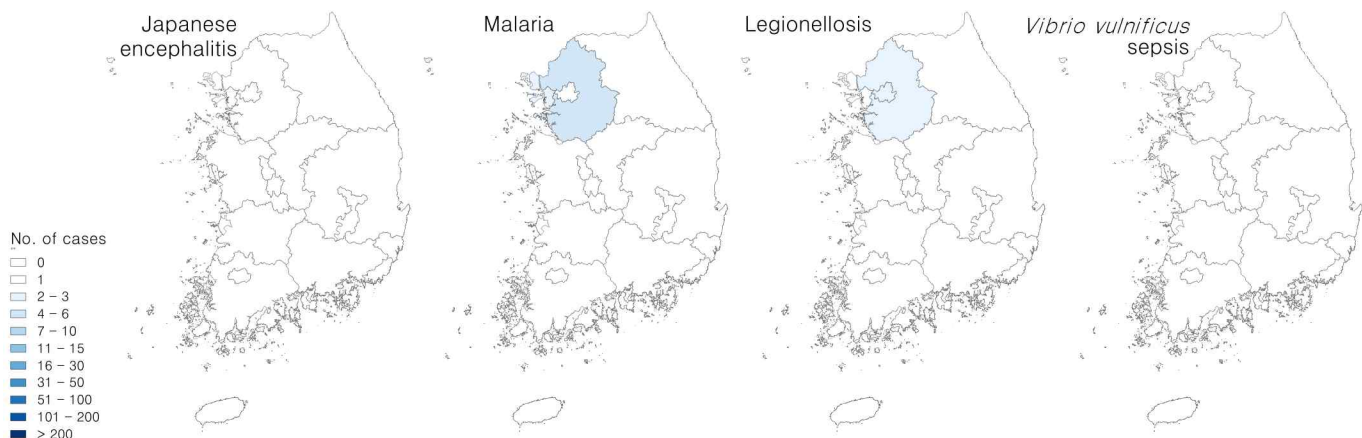
* The reported data for year 2026 is provisional, whereas data from 2021 to 2025 are finalized.

† The reported cases contain all case classifications such as confirmed, suspected, and asymptomatic carrier of the disease.

§ Cum. 5-year average is mean value calculated by cumulative counts from 1st week to current week for 5 preceding years.

‡ Gwangju Metropolitan City and Jeollanam-do were integrated into Jeonnam-Gwangju Special Metropolitan City from July 2026 due to the reorganization of the local administrative system, and the cumulative statistics of Jeonnam-Gwangju included the reported cases of Gwangju, Jeollanam-do, and Jeonnam-Gwangju.

※ Weekly reported cases of notifiable diseases, by geography



2. (Continued) Reported cases by geography, week ending September 12, 2026 (37th Week)*

Unit: no. of cases[†]

Reporting area	Diseases of Category III											
	Murine typhus			Scrub typhus			Leptospirosis			Brucellosis		
	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]
Overall	0	3	11	3	135	717	0	18	44	0	2	3
Seoul	0	0	1	0	7	14	0	0	1	0	0	0
Jeonnam Gwangju [‡]	0	0	1	1	22	236	0	4	10	0	0	1
Busan	0	0	1	0	6	20	0	0	2	0	1	0
Daegu	0	0	0	0	2	7	0	1	0	0	0	0
Incheon	0	1	3	0	0	5	0	0	1	0	0	0
Daejeon	0	0	0	0	1	13	0	1	1	0	0	0
Ulsan	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0
Sejong	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Gyeonggi	0	1	2	0	9	33	0	1	3	0	0	1
Gangwon	0	0	0	0	4	7	0	0	2	0	0	0
Chungbuk	0	0	0	0	3	12	0	1	2	0	0	0
Chungnam	0	0	1	1	10	55	0	6	9	0	0	0
Jeonbuk	0	1	1	0	23	128	0	3	6	0	0	0
Gyeongbuk	0	0	0	0	3	17	0	1	4	0	1	0
Gyeongnam	0	0	1	1	39	154	0	0	3	0	0	1
Jeju	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0

Cum: Cumulative counts from 1st week to current week in a year

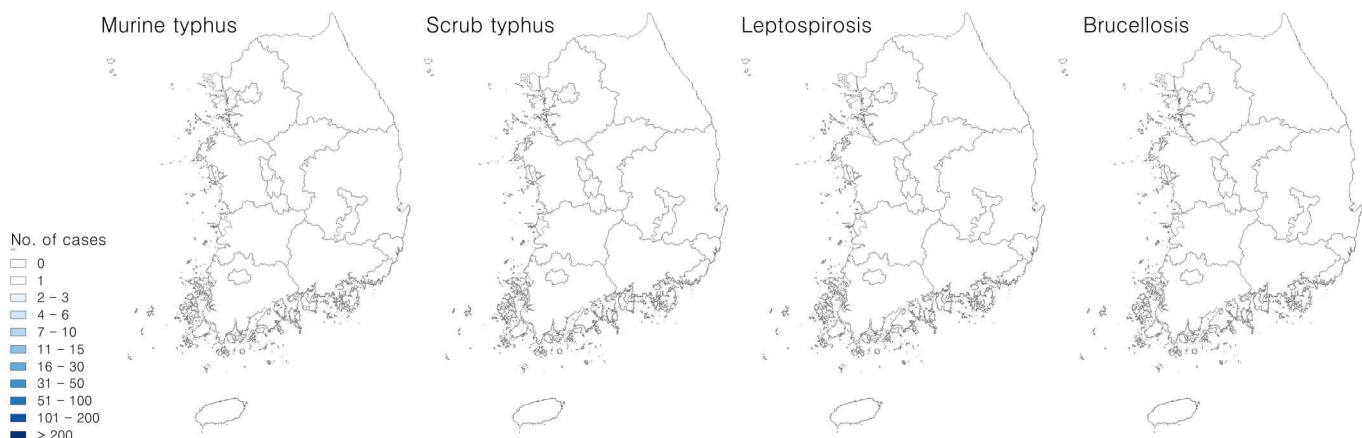
* The reported data for year 2026 is provisional, whereas data from 2021 to 2025 are finalized.

† The reported cases contain all case classifications such as confirmed, suspected, and asymptomatic carrier of the disease.

§ Cum. 5-year average is mean value calculated by cumulative counts from 1st week to current week for 5 preceding years.

‡ Gwangju Metropolitan City and Jeollanam-do were integrated into Jeonnam-Gwangju Special Metropolitan City from July 2026 due to the reorganization of the local administrative system, and the cumulative statistics of Jeonnam-Gwangju included the reported cases of Gwangju, Jeollanam-do, and Jeonnam-Gwangju.

※ Weekly reported cases of notifiable diseases, by geography



2. (Continued) Reported cases by geography, week ending September 12, 2026 (37th Week)*

Unit: no. of cases[†]

Reporting area	Diseases of Category III											
	Hemorrhagic fever with renal syndrome			Creutzfeldt-Jacob Disease			Dengue fever			Q fever		
	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]
Overall	2	85	161	0	38	49	9	62	82	1	78	95
Seoul	0	3	2	0	3	10	2	14	25	0	9	11
Jeonnam Gwangju [‡]	0	14	33	0	0	3	2	5	5	0	3	3
Busan	0	1	3	0	3	5	0	2	5	0	0	2
Daegu	0	1	2	0	0	2	0	3	1	1	5	1
Incheon	0	3	2	0	4	3	1	4	7	0	0	10
Daejeon	0	1	2	0	2	1	1	4	1	0	1	3
Ulsan	0	1	1	0	4	1	0	1	1	0	1	1
Sejong	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Gyeonggi	0	7	25	0	12	14	2	12	23	0	16	44
Gangwon	0	4	12	0	1	2	0	4	2	0	2	2
Chungbuk	1	6	3	0	2	1	0	2	2	0	6	6
Chungnam	0	14	21	0	1	1	0	3	2	0	13	5
Jeonbuk	1	7	27	0	1	1	1	2	2	0	4	1
Gyeongbuk	0	17	10	0	2	2	0	0	2	0	14	4
Gyeongnam	0	6	14	0	2	2	0	3	3	0	3	2
Jeju	0	0	3	0	1	1	0	2	1	0	0	0

Cum: Cumulative counts from 1st week to current week in a year

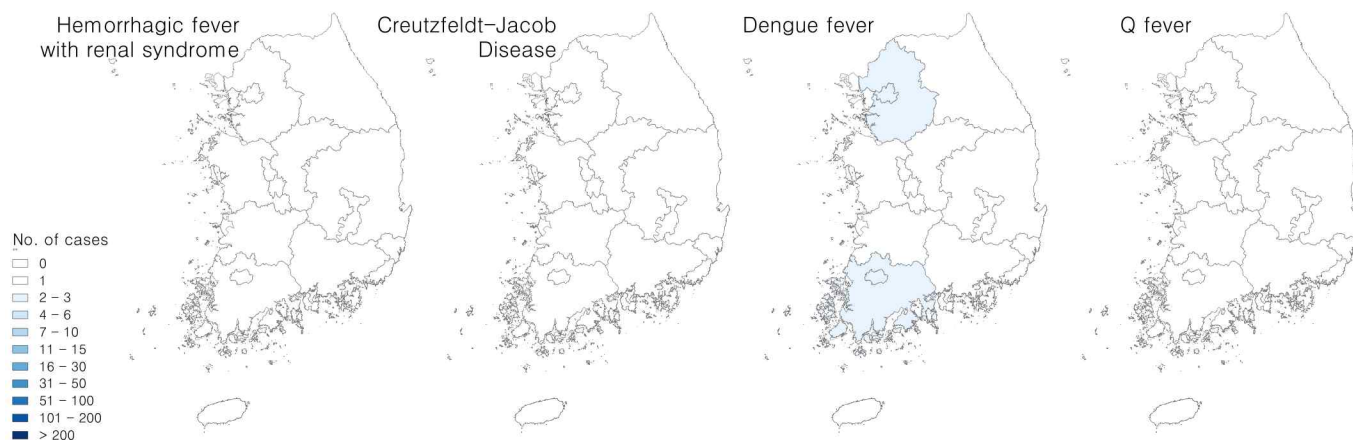
* The reported data for year 2026 is provisional, whereas data from 2021 to 2025 are finalized.

† The reported cases contain all case classifications such as confirmed, suspected, and asymptomatic carrier of the disease.

§ Cum. 5-year average is mean value calculated by cumulative counts from 1st week to current week for 5 preceding years.

‡ Gwangju Metropolitan City and Jeollanam-do were integrated into Jeonnam-Gwangju Special Metropolitan City from July 2026 due to the reorganization of the local administrative system, and the cumulative statistics of Jeonnam-Gwangju included the reported cases of Gwangju, Jeollanam-do, and Jeonnam-Gwangju.

※ Weekly reported cases of notifiable diseases, by geography



2. (Continued) Reported cases by geography, week ending September 12, 2026 (37th Week)*

Unit: no. of cases[†]

Reporting area	Diseases of Category III								
	Lyme Borreliosis			Severe fever with thrombocytopenia syndrome			Zika virus infection		
	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]
Overall	0	27	18	1	97	127	0	3	0
Seoul	0	4	5	0	7	7	0	1	0
Jeonnam Gwangju [‡]	0	0	0	1	6	10	0	1	0
Busan	0	0	0	0	3	2	0	0	0
Daegu	0	0	0	0	3	5	0	1	0
Incheon	0	2	2	0	5	1	0	0	0
Daejeon	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Ulsan	0	0	0	0	1	4	0	0	0
Sejong	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Gyeonggi	0	11	6	0	13	19	0	0	0
Gangwon	0	3	0	0	9	13	0	0	0
Chungbuk	0	1	1	0	3	6	0	0	0
Chungnam	0	3	1	0	9	8	0	0	0
Jeonbuk	0	0	0	0	9	9	0	0	0
Gyeongbuk	0	2	1	0	11	18	0	0	0
Gyeongnam	0	0	2	0	8	12	0	0	0
Jeju	0	1	0	0	7	9	0	0	0

Cum: Cumulative counts from 1st week to current week in a year

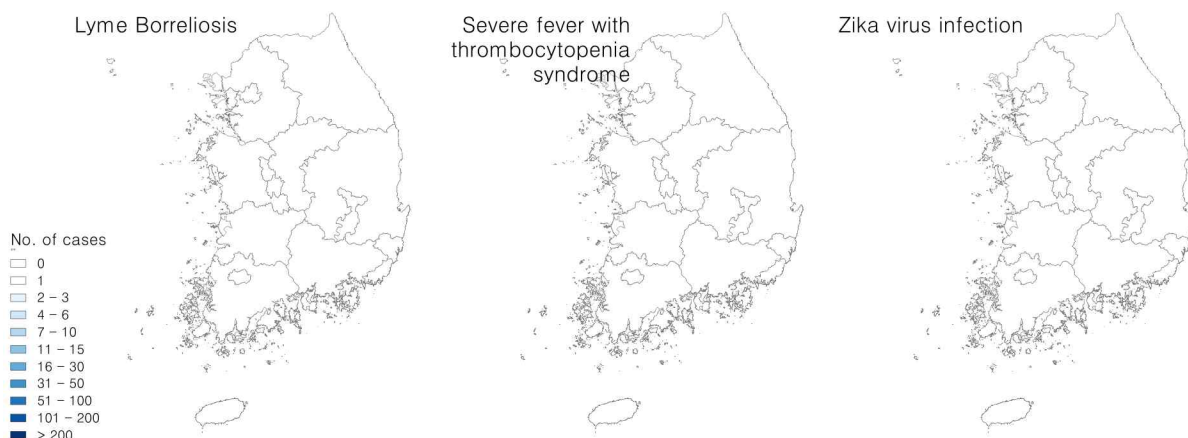
* The reported data for year 2026 is provisional, whereas data from 2021 to 2025 are finalized.

† The reported cases contain all case classifications such as confirmed, suspected, and asymptomatic carrier of the disease.

§ Cum. 5-year average is mean value calculated by cumulative counts from 1st week to current week for 5 preceding years.

‡ Gwangju Metropolitan City and Jeollanam-do were integrated into Jeonnam-Gwangju Special Metropolitan City from July 2026 due to the reorganization of the local administrative system, and the cumulative statistics of Jeonnam-Gwangju included the reported cases of Gwangju, Jeollanam-do, and Jeonnam-Gwangju.

※ Weekly reported cases of notifiable diseases, by geography



II. Sentinel-Reporting Infectious Diseases

1. Influenza, week ending September 5, 2026 (36th Week)

- Weekly proportion of influenza-like illness per 1,000 outpatients: 25.3 cases (=2.5%)
- Trend: increase from 13.3 cases in 35th week of 2026
- Sentinel reporting sites: 778 primary clinics
- ※ 2026-2027 outbreak standard: 12.9 cases(/1,000)

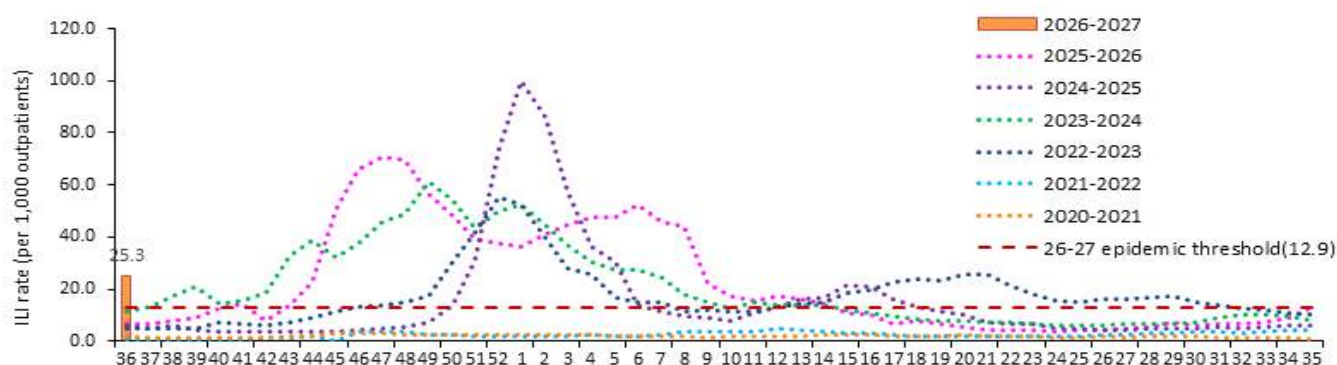


Figure 1. Weekly proportion of influenza-like illness per 1,000 outpatients, 2020-2021 to 2026-2027 flu seasons

2. Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD), week ending September 12, 2026 (37th Week)

- Weekly proportion of hand, foot and mouth disease (HFMD) per 1,000 outpatients: 15.0 cases
- Trend: decrease from 18.6 cases in 36th week of 2026
- Sentinel reporting sites: 92 pediatric clinics

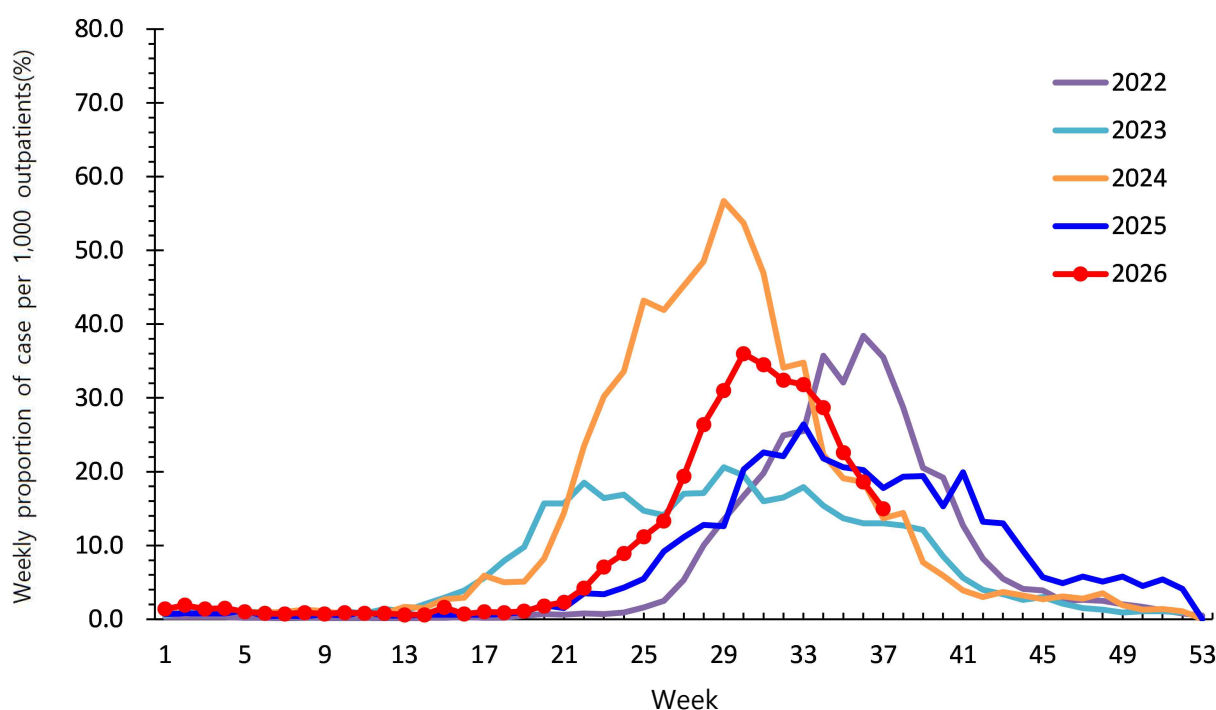


Figure 2. Weekly proportion of clinically suspected HFMD case per 1,000 outpatients, 2022-2026

3. Ophthalmologic infectious diseases, week ending September 5, 2026 (36th Week)

- Weekly proportion of clinically suspected epidemic keratoconjunctivitis case per 1,000 outpatients: 10.1 cases
- Trend: increase from 8.4 cases in 35th week of 2026
- Sentinel reporting sites: 77 clinics

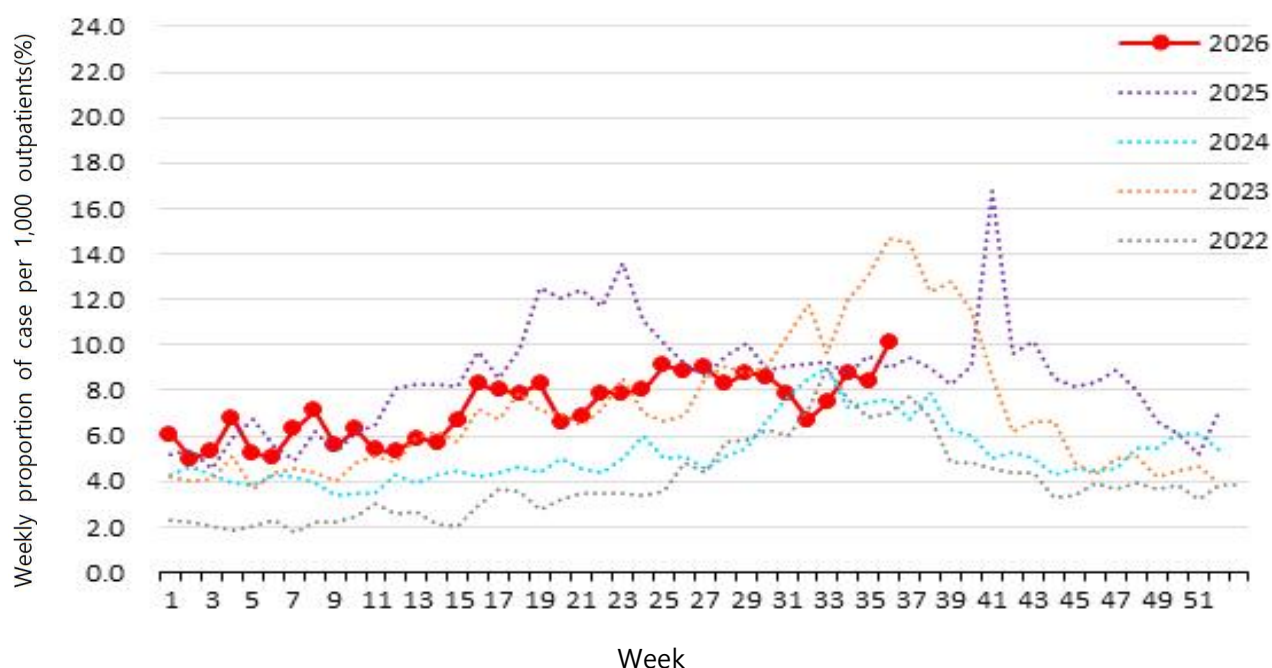


Figure 3. Weekly proportion of clinically suspected epidemic keratoconjunctivitis case per 1,000 outpatients, 2022-2026

- Weekly proportion of clinically suspected acute hemorrhagic conjunctivitis case per 1,000 outpatients: 0.6 case
- Trend: decrease from 0.7 case in 35th week of 2026
- Sentinel reporting sites: 77 clinics

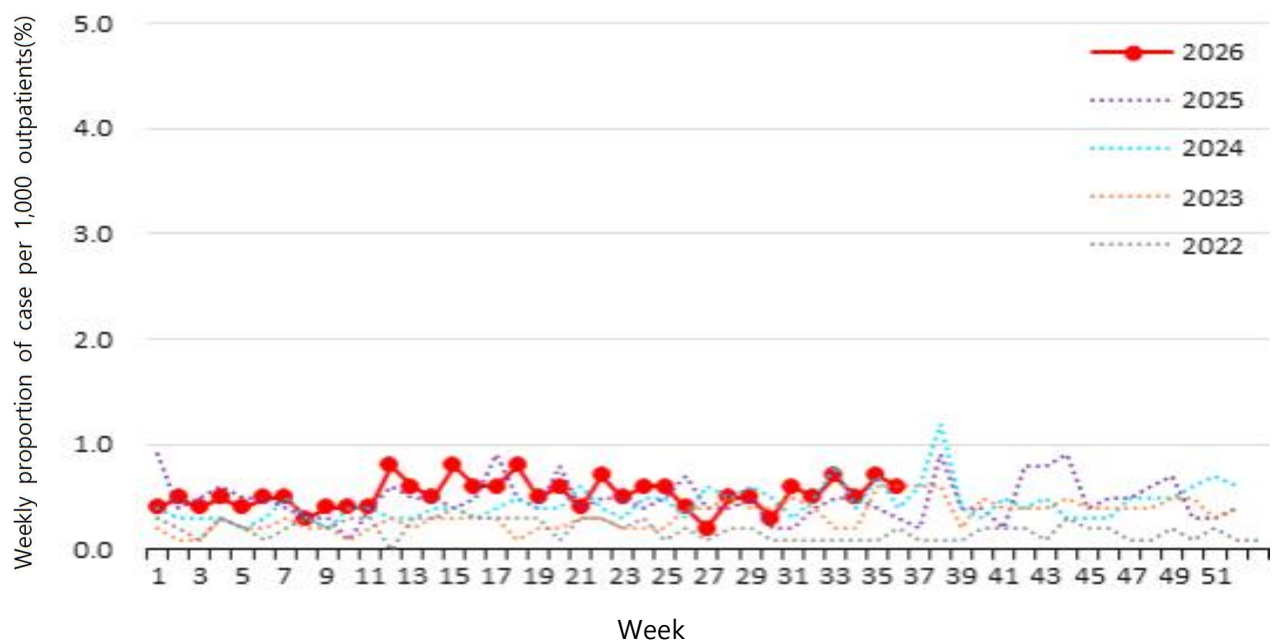


Figure 4. Weekly proportion of clinically suspected acute hemorrhagic conjunctivitis case per 1,000 outpatients, 2022-2026

4. Sexually Transmitted Diseases[†], week ending September 12, 2026 (37th Week)

- **Cases per sentinel:** 3.8 for Human Papilloma virus infection, 2.4 for Genital herpes, 1.4 for Chlamydia, 1.3 for Condyloma acuminata, 1.0 for Gonorrhea
- **Variation from 36th week of 2026**
 increase: Human Papilloma virus infection (3.3→3.8), Chlamydia (1.3→1.4)
 decrease: Genital herpes (2.5→2.4), Condyloma acuminata (1.7→1.3), Gonorrhea (1.3→1.0)
- Sentinel reporting sites: 560 hospitals/clinics
 ※ No. of reported sites in 37th week: 18 for Gonorrhea, 72 for Chlamydia, 78 for Genital herpes, 30 for Condyloma acuminata, 78 for Human Papilloma virus infection

Unit: no. of cases/sentinels

Gonorrhea			Chlamydia			Genital herpes		
Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]
1.0	3.1	5.1	1.4	12.5	17.5	2.4	40.1	38.7

Condyloma acuminata			Human Papilloma virus infection		
Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]	Current week	Cum. 2026	Cum. 5-year average [§]
1.3	12.1	15.3	3.8	72.8	73.1

Cum: Cumulative counts from 1st week to current week in a year

[†] According to surveillance data, the reported cases may include all of the cases such as confirmed, suspected, and asymptomatic carrier in the group.

[§] Cum. 5-year average is mean value calculated by cumulative counts from 1st week to current week for 5 preceding years.

III. Waterborne and Foodborne Infectious Diseases

1. Waterborne and foodborne disease outbreaks, week ending September 12, 2026 (37th Week)

- No. of reported cases: 12 outbreaks with 93 patients (cumulative no.: 574 outbreaks with 14,000 patients)
- Trend: decrease from 13 outbreaks in 36th week of 2026

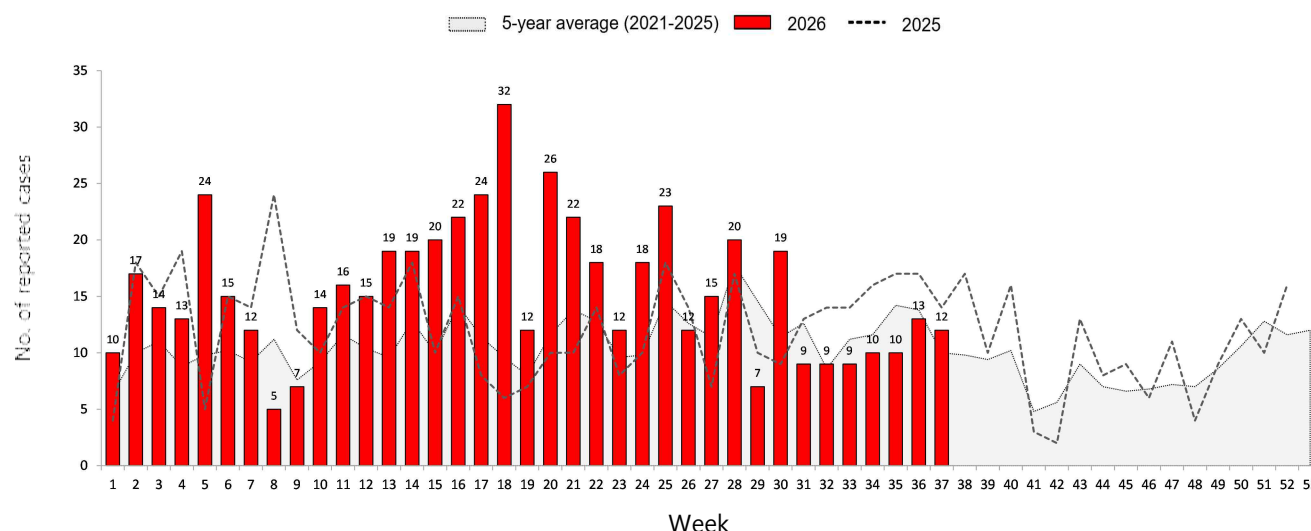


Figure 5. Number of waterborne and foodborne disease outbreaks reported by week, 2025-2026

IV. Laboratory-based Pathogen Surveillance: Influenza and Respiratory Viruses

1. Influenza viruses, week ending September 12, 2026 (37th Week)

- Weekly reported number of specimens positive for influenza: 24.6%
[influenza subtype: A(H1N1)pdm09 24.2%, A(H3N2) 0.2%, B 0.2%]
- Variation (%p): increase from 16.3% in 36th week of 2026
- Sentinel reporting sites: 109 hospitals/clinics

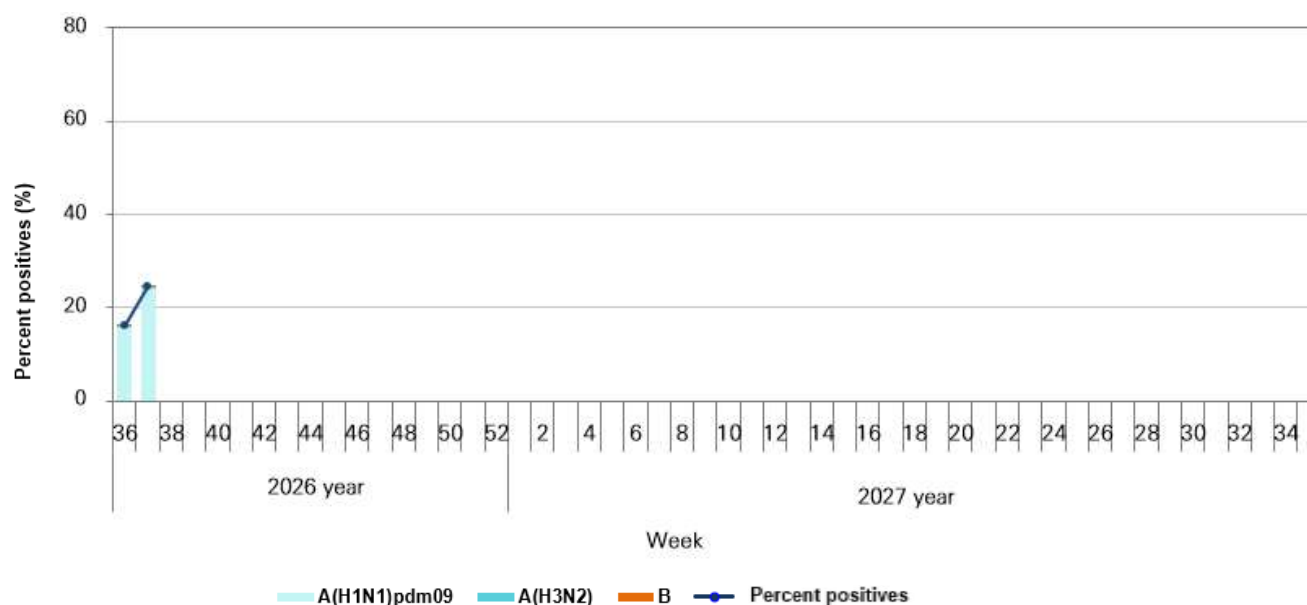


Figure 6. Number of specimens positive for influenza by subtype, 2026-2027 flu season

2. Respiratory viruses, week ending September 12, 2026 (37th Week)

- Detection rate: 71.1% (cumulative mean proportion during preceding three weeks plus current week: 66.2%)
- Variation (%p): increase from 65.5% in 36th week of 2026
- Sentinel reporting sites: 18 city/provincial health and environmental institutes and 106 hospitals/clinics

Week	Weekly total		Detection rate (%)								
		Detection rate (%)	HAdV	HBoV	HPIV	HRSV	HRV	HMPV	HCoV	IFV	SARS-CoV-2
2026	34	59.7	3.2	2.3	14.0	2.3	12.7	3.6	0.5	10.0	11.3
	35	64.1	3.9	2.2	11.7	1.1	17.3	3.9	0.0	12.3	11.7
	36	65.5	2.4	1.7	10.3	0.9	13.3	3.4	0.9	16.3	16.3
	37	71.1	3.3	1.8	7.7	0.8	15.7	2.0	1.0	24.6	14.2
Cum.*		66.2	3.2	1.9	10.3	1.1	14.9	3.1	0.6	17.2	13.8
2026 Cum.†		76.5	3.6	3.4	11.0	5.3	16.8	7.1	9.4	15.8	4.2

- HAdV : human Adenovirus, HPIV : human Parainfluenza virus, HRSV : human Respiratory syncytial virus, IFV : Influenza virus, HCoV : human Coronavirus, HRV : human Rhinovirus, HBoV : human Bocavirus, HMPV : human Metapneumovirus

* Cum. : the rate of detected cases between August 16, 2026 - September 12, 2026

† 2026 Cum. : the rate of detected cases between December 28, 2025 - September 12, 2026

V. Laboratory-based Pathogen Surveillance: Acute Gastroenteritis Viruses/Bacteria

1. Acute gastroenteritis-causing virus, week ending September 5, 2026 (36th Week)

- Detection rate: 19.2% (cumulative mean proportion in 2026: 1,151 cases [40.2%] out of 2,860 specimens)
- Variation (%p): decrease from 20.5% in 35th week of 2026
- Sentinel reporting sites: 18 city/provincial health and environmental institutes and 72 hospitals/clinics

Week		No. of sample	No. of detection (Detection rate, %)											
			Norovirus		Group A Rotavirus		Enteric Adenovirus		Astrovirus		Sapovirus		Total	
2026	33	67	2	(3.0)	0	(0.0)	3	(4.5)	1	(1.5)	3	(4.5)	9	(13.4)
	34	66	1	(1.5)	0	(0.0)	6	(9.1)	0	(0.0)	3	(4.5)	10	(15.2)
	35	73	2	(2.7)	0	(0.0)	6	(8.2)	2	(2.7)	5	(6.8)	15	(20.5)
	36	73	0	(0.0)	0	(0.0)	6	(8.2)	3	(4.1)	5	(6.8)	14	(19.2)
2026 Cum.		2,860	827	(28.9)	102	(3.6)	125	(4.4)	62	(2.2)	35	(1.2)	1,151	(40.2)

* The samples were collected from children ≤5 years of sporadic acute gastroenteritis in Korea.

2. Acute gastroenteritis-causing bacteria, week ending September 5, 2026 (36th Week)

- Detection rate: 24.2% (cumulative mean proportion in 2026: 1,450 cases [14.0%] out of 10,346 specimens)
- Variation (%p): decrease from 23.5% in 35th week of 2026
- Sentinel reporting sites: 18 city/provincial health and environmental institutes and 76 hospitals/clinics

Week		No. of Sample	No. of isolation (Isolation rate, %)									
			<i>Salmonella</i> spp.	Pathogenic <i>E.coli</i>	<i>Shigella</i> spp.	<i>V.parahae molyticus</i>	<i>V.cholerae</i>	<i>Campylobacter</i> spp.	<i>C.perfringens</i>	<i>S. aureus</i>	<i>B. cereus</i>	Total
2026	33	251	21 (8.4)	21 (8.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.8)	10 (4.0)	5 (2.0)	59 (23.5)
	34	286	19 (6.6)	45 (15.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (1.0)	5 (1.7)	12 (4.2)	8 (2.8)	92 (32.2)
	35	247	19 (7.7)	19 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	2 (0.8)	11 (4.5)	5 (2.0)	58 (23.5)
	36	207	14 (6.8)	23 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	7 (3.4)	5 (2.4)	50 (24.2)
2026 Cum.		10,346	280 (2.7)	421 (4.1)	0 (0.0)	1 (0.01)	0 (0.0)	96 (0.9)	206 (2.0)	225 (2.2)	207 (2.0)	1,450 (14.0)

* Bacterial Pathogens ; *Salmonella* spp., *E. coli* (EHEC, ETEC, EPEC, EIEC), *Shigella* spp., *Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio cholerae*, *Campylobacter* spp., *Clostridium perfringens*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus*, *Listeria monocytogenes*, *Yersinia enterocolitica*.

VI. Laboratory-based Pathogen Surveillance: Enterovirus

1. Enterovirus, week ending September 5, 2026 (36th Week)

- Detection rate: 59.4% (19 cases / 32 specimens) (cumulative mean proportion in 2026: 42.4% [386 cases / 911 specimens])
 - Aseptic meningitis: 0 case (Cum. 2026: 3 cases)
 - HFMD and herpangina: 14 cases (Cum. 2026: 248 cases)
 - HFMD with complications: 0 case (Cum. 2026: 5 cases)
 - Other: 5 cases (Cum. 2026: 130 cases)
- Variation (%p): increase from 48.6% in 35th week of 2026
- Sentinel reporting sites: 18 city/provincial health and environmental institutes and 83 hospitals/clinics

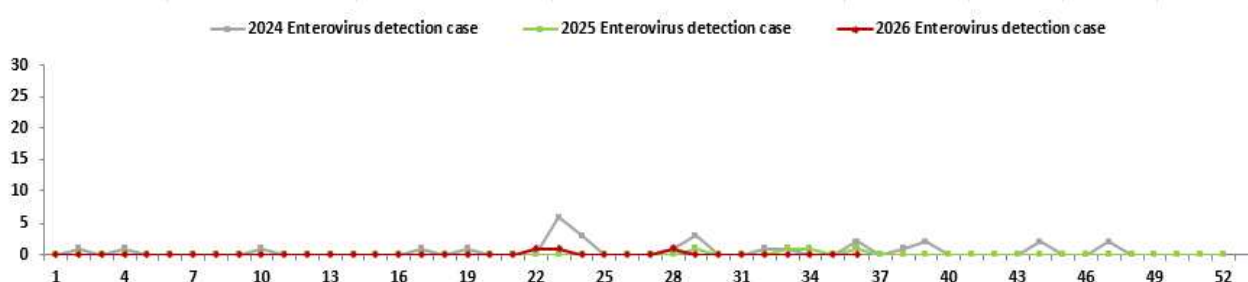


Figure 7. Detection of enterovirus in aseptic meningitis patients from 2024 to 2026

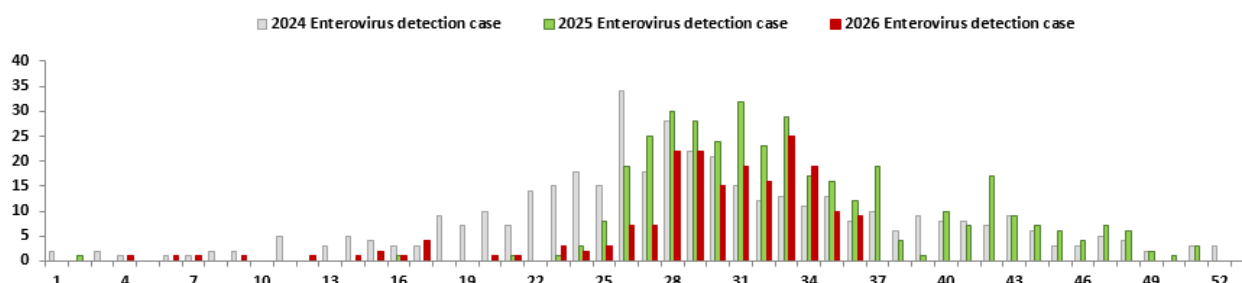


Figure 8. Detection of enterovirus in HFMD and herpangina patients from 2024 to 2026

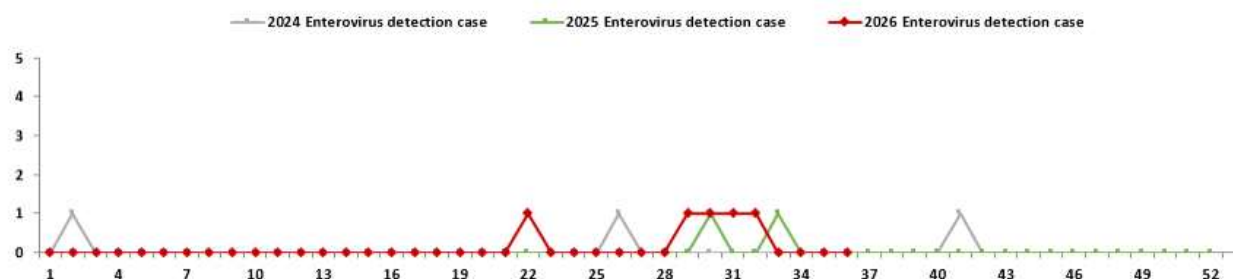


Figure 9. Detection of enterovirus in HFMD with complications patients from 2024 to 2026

VII. Vector Surveillance: Malaria vector Mosquitoes

1. Malaria vector mosquitoes, week ending September 5, 2026 (36th Week)

- No. of malaria vector mosquitoes: 3.2
- Variation: decrease from 5.0 in 36th week of 2025
- Sentinel reporting sites: 4 city/province (88 sites)
- ※ No. of mosquitoes: average number of mosquitoes/trap/day

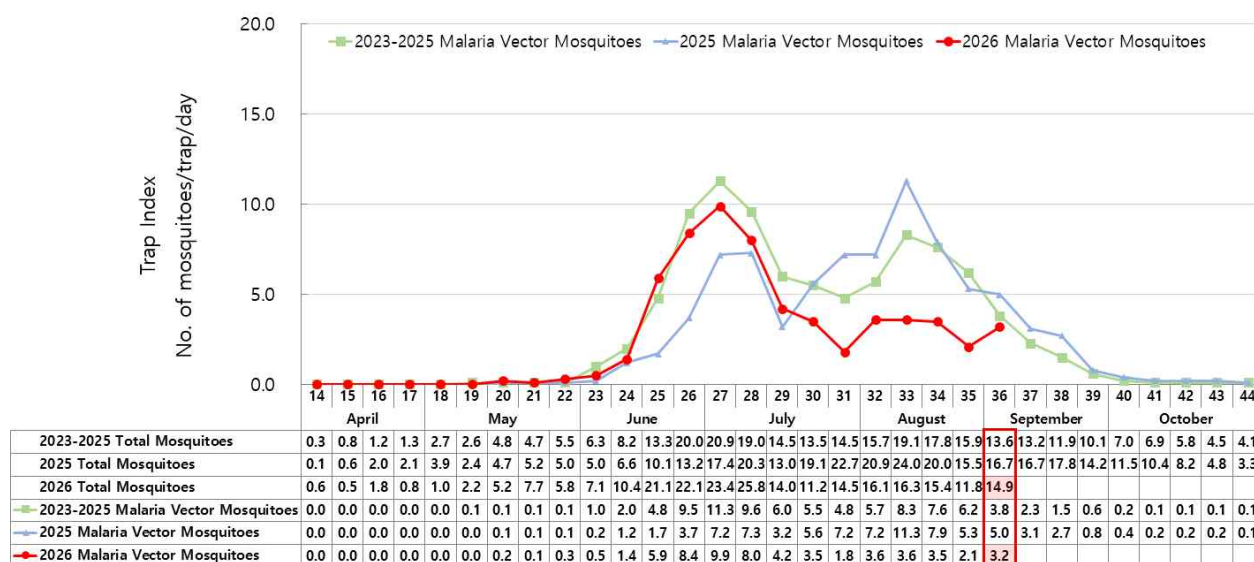


Figure 10. Weekly incidences of malaria vector mosquitoes

VIII. Vector Surveillance: Japanese encephalitis vector Mosquitoes

1. Japanese encephalitis vector mosquitoes, week ending September 12, 2026 (37th Week)

- No. of Japanese encephalitis vector mosquitoes: 77
 - Variation: decrease from 301 in 37th week of 2025
 - Sentinel reporting sites: 12 city/provincial health and environmental institutes (14 sites)
- ※ No. of mosquitoes (Trap index, TI): average number of mosquitoes/trap/day

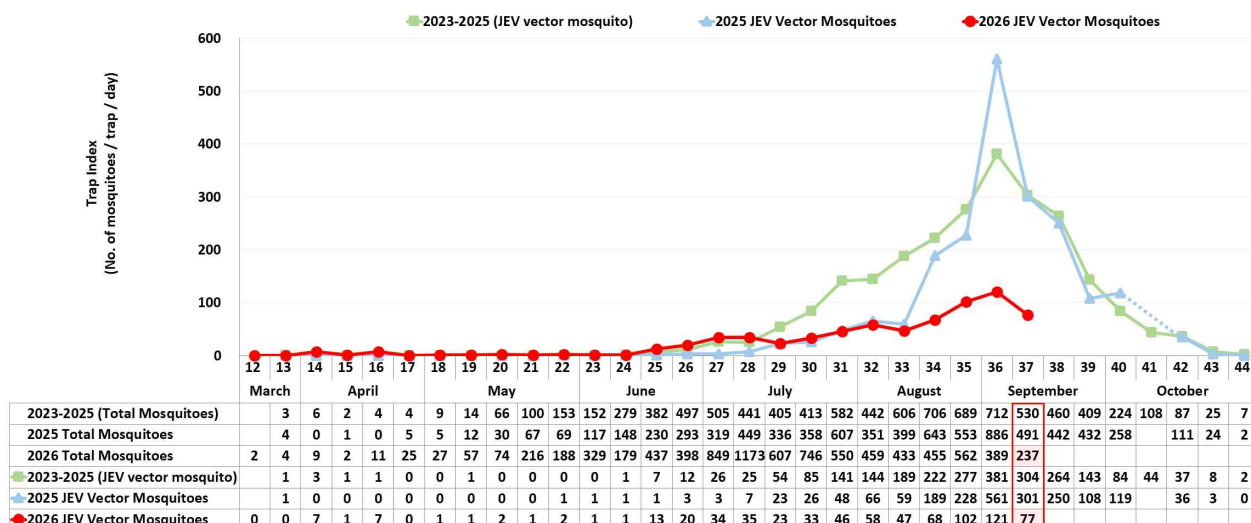


Figure 11. Weekly incidence of Japanese encephalitis vector mosquitoes

- ※ Due to Thanksgiving holiday, Japanese encephalitis mosquitoes were not collected in 41st week of 2025.
- ※ First vector collection of 2026 performed in Week 12 due to the extended surveillance period.

IX. Vector Surveillance: Scrub typhus vector chigger mites

1. Scrub typhus vector chigger mites, week ending September 12, 2026 (37th Week)

- No. of chigger mites: 0.00
- Variation: no change from 0.00 in 37th week of 2025
- Sentinel reporting sites: 9 city/province (18 sites)
- ※ No. of chigger mites: number of chigger in 18 sites (360 traps) per week

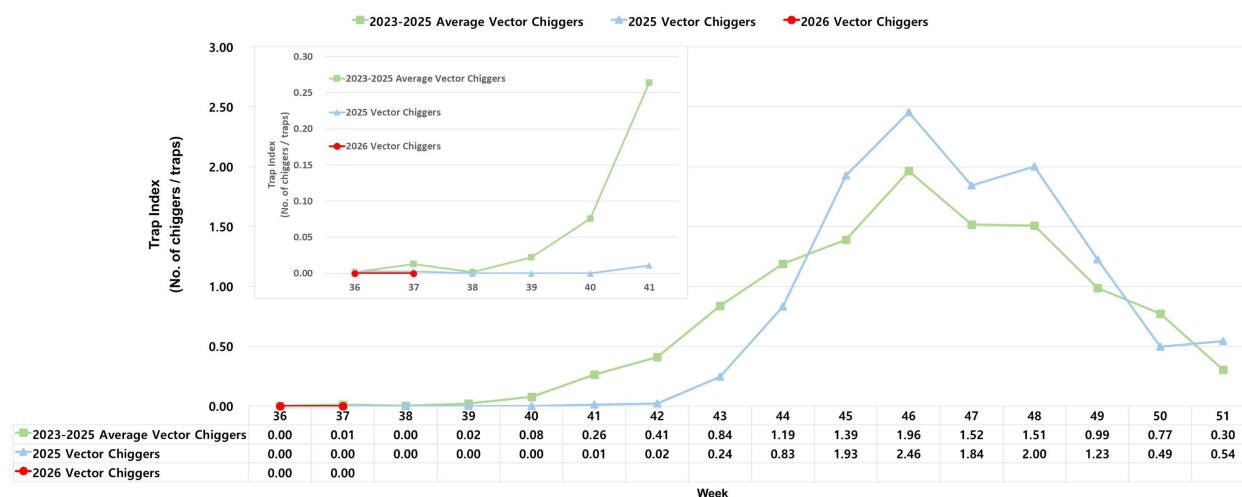


Figure 12. Weekly incidence of scrub typhus vector chiggers

About PHWR Surveillance Statistics of Infectious Diseases

The Public Health Weekly Report (PHWR) Surveillance Statistics of Infectious Disease is prepared by the Korea Disease Control and Prevention Agency (KCDA). These provisional surveillance data on the reported occurrence of national notifiable diseases and conditions are compiled through population-based or sentinel-based surveillance systems and published weekly, except for data on infrequent or recently-designated diseases. These surveillance statistics are informative for analyzing infectious disease or condition numbers and trends. However, the completeness of data might be influenced by some factors such as a date of symptom or disease onset, diagnosis, laboratory result, reporting of a case to a jurisdiction, or notification to Korea Disease Control and Prevention Agency. The official and final disease statistics are published in infectious disease surveillance yearbook annually.

Using and Interpreting These Data in Tables

- **Current Week** – The number of cases under current week denotes cases who have been reported to Korea CDC at the central level via corresponding jurisdictions(health centers, and health departments) during that week and accepted/approved by surveillance staff.
- **Cum. 2025** – For the current year, it denotes the cumulative(Cum) year-to-date provisional counts for the specified condition.
- **5-year weekly average** – The 5-year weekly average is calculated by summing, for the 5 proceeding years, the provisional incidence counts for the current week, the two weeks preceding the current week, and the two weeks following the current week. The total sum of cases is then divided by 5 weeks. It gives help to discern the statistical aberration of the specified disease incidence by comparing difference between counts under current week and 5-year weekly average.

For example,

		Week Number				
		10	11	12	13	14
Year	2025			Current week		
	2024	X1	X2	X3	X4	X5
	2023	X6	X7	X8	X9	X10
	2022	X11	X12	X13	X14	X15
	2021	X16	X17	X18	X19	X20
	2020	X21	X22	X23	X24	X25

$$\begin{aligned} &\text{5-year weekly average for current week} \\ &= (X1 + X2 + \dots + X25) / 5 \end{aligned}$$

- **Cum. 5-year average** – Mean value calculated by cumulative counts from 1st week to current week for 5 preceding years. It gives help to understand the increasing or decreasing pattern of the specific disease incidence by comparing difference between cum. 2025 and cum. 5-year average.

Contact Us

Questions or comments about the PHWR Surveillance Statistics of Infectious Disease can be sent to phwrcdc@korea.kr